INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO DE SÓCIOS COTISTAS DA CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECÓ LTDA.

Pelo presente instrumento particular, as partes, a saber:

1. **MARCOS TADEU CURY**, CPF-497.678.526-20, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Guarantã-SP, nascido em 28/01/1960, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº 111096220-5, expedida pela SSP-SP e CRM-SC nº 4667, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, a Rua Barão do Rio Branco, nº 286-D, ap. 301, Centro, CEP-
   89801-030;

2. **RAUL PERIZZOLO**, CPF-385.722.909-82, brasileiro, separado judicialmente, natural de Presidente Castelo Branco-SC, nascido em 01/11/1960, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº 842.055-6, expedida pela SSP-SC e CRM-SC nº 5171, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, a Rua Barão do Rio Branco, nº 690-D, ap. 202, Bairro Maria Goretti, CEP-89801-405;

3. **ADRIANO DALL MAGRO**, CPF-540.770.360-20, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Passo Fundo-RS, nascido em 13/06/1969, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº 2038252892, expedida pela SSP-RS e CRM-SC nº 6759, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, a Rua Uruguai, nº 321-D, ap. 702, Centro, CEP-89802-500;

4. **VICENTE ANTONIO ALVES PONS**, CPF-494.407.480-87, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Salvador-BA, nascido em

09/08/1970, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº 6044403613, expedida pela SSP-RS e CRMSC nº 7717, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, a Rua Barão do Rio Branco, 545-D, ap. 101, Bairro Centro, CEP 89801-030;

5. **MAURICIO MAHALEM BASTOS**, CPF-688.191.456-34, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Cassia-MG, nascido em 26/12/1971, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº M-5.461.818, expedida pela SSP-MG e CRM-SC nº 10.596, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Thomas Edson, nº 260-E, ap. 401, Centro, CEP-89801-136;

6. **ROSEMARY CURY**, CPF-524.964.736-72, brasileira, solteira, natural de Guarantã-SP, nascida em 02/06/1964, médica anestesista, portadora da cédula de identidade RG. nº 14.426.202, expedida pela SSPSP e CRM-SC nº 6.457, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Barão do Rio Branco, nº 244-D, Ap. 702, Centro, CEP-89801-600;

7. **HUMBERTO HEPP**, CPF-023.133.559-85, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Chapecó-SC, nascido em 30/10/1977, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº 3094203761, expedida pela SSP-SP e CRM-SC nº 12657, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Linha São Roque, sem número, Pinheirinho, CEP-89800-000;

8. **RODNEI CABRAL LIMA**, CPF-001.782.986-03, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Carangola-MG, nascido em 18/12/1975, médico anestesista, portador do CRM-SC nº 14627, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Egito, nº 179-E, ap. 101, Centro, CEP- 89801-420;

9. **MARCOS CARDOSO COSTA**, CPF-000.955.520-06, brasileiro, solteiro, natural de Santa Maria-RS, nascido em 12/11/1981, médico anestesista, portador da RG. nº 1063502775, expedida em 28/10/2008, pela SSP-RS, e CRM-SC nº 16202, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Independência, nº 532-E, ap. 301, Jardim Itália, CEP-89814-043;

10. **RAQUEL SCHNEIDER FELICIANI**, CPF-968.721.790-15, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de São José do Ouro-RS, nascida em 27/06/1981, médica anestesista, portadora da cédula de identidade RG. nº 7.514.409, expedida pela SESP-SC e CRMSC nº 18.260, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rio de Janeiro, nº 189-D, ap. 1402, Edifício Copacabana, Bairro Centro, CEP-89801-210;

11. **ALINE BOFF BONFANTE**, CPF-004.659.690-97, brasileira, casada pelo regime de separação de bens, natural de Getúlio Vargas-RS, nascida em 29/09/1984, médica anestesista, portadora da cédula de identidade RG. nº 6077930839, expedida pela SSP-RS e CRM-SC nº 15.271, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Uruguai, nº 140-D, Edifício Contemporâneo, AP. 303, Centro, CEP- 89802-500;

12. **GUSTAVO ALMANSA GARIM**, CPF-712.476.370-34, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Dom Pedrito- RS, nascido em 21/09/1974, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº 5061223649, expedida pela SSP-RS e CRM-SC nº 11.801, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 414-D, Apto. 12, Centro, CEP-89801-500;

13. **OSCAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS**, CPF-013.261.266- 60, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Ipatinga-MG, nascido em 25/11/1980, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº MG-11.750.789, expedida pela SSP-MG e CRM-SC nº 19.348, residente e domiciliado

na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Curitiba, nº 130-D, AP. 304, Centro, CEP- 89801-341;

14. **JANAINA SANCHES FAVORITO MORAIS**, CPF-298.366.108-39, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Santos-SP, nascida em 02/04/1983, médica anestesista, portadora da cédula de identidade RG. nº 21.746.176-1, expedida pela SSP-SP e CRMSC nº 20.264, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Curitiba, nº 130-D, Ap. 304, Centro, CEP-89801- 341;

15. **DIEGO BONIATTI RIGOTTI**, CPF-041.606.429-93, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos- SC, nascido em 27/04/1985, médico anestesista, portador da cédula de identidade profissional nº 17.246, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Barão do Rio Branco, nº 568-D, ap. 1901, Centro, CEP - 89802-025.

16. **FERNANDA GUOLLO**, CPF-017.930.270-13, brasileira, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Estação-RS, nascida em 26/12/1988, médica anestesista, portadora da cédula de identidade profissional, nº 019515, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, nº 55-E. ap. 1701, Bairro Centro, CEP 89801-040;

17. **GABRIELA CITRON VEDANA**, CPF-065.486.889-10, brasileira, casada pelo regime de separação de bens, natural de Chapecó-SC, nascida em 02/10/1991, médica anestesista, portadora da cédula de identidade profissional, nº 21147, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Pinheiros, nº 131-D, Ap. 301, Bairro Palmital, CEP-89814-240;

18. **GUSTAVO BIESDORF**, CPF-057.232.639-43, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 20/09/1987, médico anestesista, portador da cédula de identidade profissional nº 018409, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, nº 1510, Apto. 402, Bairro Passo dos Fortes, CEP-89801-041;

19. **ROBERTA MARINA GRANDO**, CPF-052.832.279-60, brasileira, união estável, natural de Chapecó-SC, nascida em 18/03/1986, médica anestesista, portadora da cédula de identidade profissional, nº 18871, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Sete de Setembro, 1707D, ap. 801, Edifício Dublin, Bairro Presidente Médici, CEP 89806-15;

20. **LEONARDO FERRAZZO**, CPF-074.371.679-56, brasileiro, solteiro, nascido em 29/12/1989, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº 4.864.807, expedida pela SESPDC/SC e cédula de identidade profissional nº 21490, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Avenida Nereu Ramos, 245-D, ap 1104, Bairro Centro, CEP-89801-023;

21. **MARILIO JOSÉ FLACH**, CPF-001.663.930-88, brasileiro, solteiro, nascido em 07/08/1983, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº 1073874231, expedida pela SJS/RS e cédula de identidade profissional nº 26752, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rio Branco, 453-D, Edifício Puerto Madero, ap 501, Bairro Centro, CEP-89801-030 ;

22. **FERNANDO HENRIQUE MACHADO**, CPF-020.230.620-80, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22/03/1990, médico anestesista, portador da cédula de identidade RG. nº 1099358309, expedida pela SSP/RS e cédula de identidade profissional nº 21623, expedida pelo CRMSC,

residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, nº 991-E, Apto. 07, Centro, CEP - 89801-040;

23. **LEANDRO BERNARDES**, CPF-076.844.089-09, brasileiro, solteiro, nascido em 23/04/1992, médico anestesista, portador da cédula de identidade profissional, nº 23358, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Porto, nº 97-E, Ap. 504, Bairro Presidente Médici, CEP-89801-125;

24. **CRISTINA BERTOL BARBOSA MARCON**, CPF-069.378.829-12, brasileira, casada pelo regime de separação de bens, nascida em 03/01/1990, médica anestesista, portadora da cédula de identidade profissional, nº 19932, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Marechal Jose Bormann, nº 281-D, Ap. 701, Centro, CEP-89801-050;

25. **TIAGO IOP VIANA**, CPF-040.202.859-77, brasileiro, solteiro, nascido em 29/06/1984, médico anestesista, portador da cédula de identidade profissional, nº 17960, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Av. Porto Alegre, nº 828-D, ap. 701, Edifício Capri, Centro, CEP-89802-131;

26. **GUILHERME SOUZA MELO**, CPF-025.336.589-95, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/12/1981, médico anestesista, portador da cédula de identidade profissional, nº 17400, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Lauro Muller, 385-D, ap.1602, Edifício Monet, Bairro Centro, CEP 89802-520;

27. **GUILHERME JONCK STAUB**, CPF-049.000.369-94, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 02/10/1984, médico anestesista, portador da cédula de identidade profissional, nº 019479, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua

Barão do Rio Branco, nº 580-D, ap. 1102, Edifício Mozart, Bairro Centro, CEP-89801-030;

28. **PAULO TONINI**, CPF-057.901109-75, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/07/1986, médico anestesista, portador da cédula de identidade profissional, nº 018867, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Curitiba, nº 130-D, ap. 702, Centro, CEP-89801-340;

29. **JOÃO RICARDO MOREIRA**, CPF-075.925.109-60, brasileiro, união estável, nascido em 31/12/1989, médico anestesista, portador da cédula de identidade profissional, nº 25795, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Servidão Turquia, nº 135-E, apto. 1302, Edifício Stella Maris, Bairro Presidente Médici, CEP-89801-303.

30. **ALEXANDRE SILVA DANIELI**, CPF-979.119.500-59, brasileiro, união estável, nascido em 29/05/1982, médico anestesista, portador da cédula de identidade profissional, nº 18886, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Hugo de Almeida Campos, nº 60-E, apto. 403, Edifício Campos, Bairro Passo dos Fortes, CEP-89805-059;

31. **ALEXANDRE SCHMIDT**, CPF-819.920.680-20, brasileiro, união estável, nascido em 22/07/1982, médico anestesista, portador da carteira profissional de médico, inscrição nº 25707, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rio de Janeiro, nº 189-D, Apt. 1201, Centro, CEP-89801-210;

32. **GIOVANA GOMES NOLL**, CPF-027.542.000-02, brasileira, solteira, nascida em 24/05/1993, médica anestesista, portadora da carteira profissional de médico, inscrição nº 26735, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliada na Cidade de

Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Guaporé, nº 118-E, Apt. 1903, Centro, CEP-89802-300;

33. **KLISMAN DRESCHER HILLESHEIN**, CPF-079.700.949-37, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 20/01/1992, médico anestesista, portador da carteira profissional de médico, inscrição nº 23823, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Rua Edy Remy Aiolfi, nº 401, Bairro Paraíso, CEP-89806-273;

34. **EDUARDO SCHMIDT SAVOLDI**, CPF-087.759.129-61, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1993, médico anestesista, portador da carteira profissional de médico, inscrição nº 23695, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Av. Nereu Ramos, 1040-E, Apto. 1203, Bairro Presidente Médici, CEP- 89801-106;

35. **MATHEUS LEMOS VIEIRA DA CUNHA**, CPF 052.482.859-84, brasileiro, união estável, nascido em 28/10/1985, médico anestesista, portador da carteira profissional de médico, inscrição n° 20708, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Assis Brasil, 620-E, Apto. 601, Bairro Maria Goretti, CEP – 89801-355;

36. **LOUISE MACAGNAN WARNAVA**, CPF 057.504.069-62, brasileira, solteira, nascida em 09/07/1989, médica anestesista, portadora da carteira profissional de médico, inscrição n° 25139, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Av. Nereu Ramos, 382-E, Apto. 1101, Bairro Centro, CEP – 89801-020;

37. **THAYNA REGINA SANTOS**, CPF 093.390.859-81, brasileira, união estável, nascida em 07/10/1995, médica anestesista, portadora da carteira profissional de médico, inscrição n° 27710, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliada na

Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Guaporé, 136-D, Apto. 1806, Bairro Centro, CEP – 89801-085;

38. **ERLEI PERINI**, CPF 006.420.760-90, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 09/05/1985, médico anestesista, portador da carteira profissional de médico, inscrição n° 27713, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 555-L, Apto. 2001, Bairro Centro, CEP – 89801-500;

39. **KARINE BEDIN**, CPF 036.397.560-88, brasileira, solteira, nascida em 09/11/1995, médica anestesista, portadora da carteira profissional de médico, inscrição n° 40066, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliada na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Guaporé, 136-D, Apto. 2803, Bairro Centro, CEP – 89802-310;

40. **GABRIEL JUAN KETTENHUBER COSTA**, CPF 029.613.660-38, brasileiro, solteiro, nascido em 28/04/1995, médico anestesista, portador da carteira profissional de médico, inscrição n° 32337, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Guaporé, 136-D, Apto. 2803, Bairro Centro, CEP – 89802-310;

41. **RAFAEL PELISSARO**, CPF 060.561.929-89, brasileiro, solteiro, nascido em 01/04/1996, médico anestesista, portador da carteira profissional de médico, inscrição n° 32159, expedida pelo CRM-SC, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Av. Nereu Ramos, 5146-E, Apto. 1102, Bairro Centro, CEP – 89801-020;

Detentores, em conjunto, de 100% (cem por cento) do capital social votante da **CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECÓ LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.127.537/0001-78, com sede na Rua Assis

Brasil, 404-E, Bairro Maria Goretti, CEP 89801-355, na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, vêm, por meio deste Instrumento Particular de Acordo de Sócios Cotistas, estabelecer o que segue:

Preâmbulo

CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECÓ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, criada no ano de 2020, com propósito específico de prestar assistência anestesiológica e analgesia a pacientes que dela precisarem, respeitando as normas técnicas impostas pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e Conselho Federal de Medicina, através de seus médicos sócios cotistas, pretende instituir por este instrumento um pacto parassocial, a fim de disciplinar temas específicos de interesse dos sócios, estabelecer regras de condução dos negócios e, de consequência, prevenir conflitos durante a realização das atividades societárias;

(i) Os Sócios detêm conjuntamente 100% (cem por cento) das cotas de emissão da Sociedade;

(ii) Os Sócios entendem e reconhecem a importância da confiança mútua e forte espírito de parceria entre eles na condução da Sociedade, como a aqui contemplada, os Sócios concordam em envidar seus melhores esforços para tomar todas as decisões relevantes relacionadas à operação da Sociedade em questão, tendo decidido celebrar este Acordo entre Sócios para determinar entre eles princípios de orientação quanto a seus direitos, obrigações e administração da Sociedade.

(iii) Este Acordo de Cotistas prescreverá as diretrizes fundamentais de um regime de governança para que a sociedade empresária garanta transparência, solidez e segurança a seus sócios cotistas.

(iv) Outros elementos da governança trazidos neste Acordo abrangem: (a) membros que compõem a sociedade; (b) inclusão de novos sócios; (c) obrigações dos sócios; (d) patrimônio da sociedade empresária; (e) divisão

do trabalho e contraprestações; (f) férias; (g) afastamento dos sócios; (h) aposentadoria; (i) responsabilidade civil dos médicos cotistas; (j) aplicações financeiras; (k) sanções

RESOLVEM as partes acima qualificadas, todos sócios da **CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECÓ LTDA**, assinam o presente Acordo Societário, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE DO ACORDO

O presente Acordo tem como objeto a indicação das diretrizes no tocante a gestão de equipe, controle financeiro, composição societária, administração do negócio e demais detalhes a serem seguidos pelas partes supracitadas para que haja a harmonia empresarial e boa comunicação em prol do desenvolvimento da ANEST, incluindo, mas não se limitando:

a) Quem são os membros que compõem a sociedade;
b) Métodos e diretrizes para admissão de novos sócios;
c) Obrigações e deveres dos sócios;
d) Informações acerca do patrimônio da sociedade empresária;
e) Indicativos das Aplicações financeiras que existem e serão realizadas;
f) Indicações de como proceder-se-á a divisão do trabalho entre os médicos anestesiologistas e contraprestações que farão *jus*;
g) Escala de férias;
h) Diretrizes de quais serão os afastamentos permitidos para cada médico anestesiologista e como se procederá;
i) Preenchimento de requisitos para aposentadoria e contraprestação;
j) Orientações quanto a responsabilidade civil dos médicos cotistas;
k) Sanções aos sócios quanto necessárias.

Parágrafo Primeiro:

Nesse sentido, os sócios cotistas se utilizam deste instrumento para disciplinar o relacionamento entre si e perante a **ANEST**, tendo como objetivo primordial resguardar a continuidade do desenvolvimento e aprimoramento dos negócios e das atividades sociais a serem desenvolvidas, sempre em observância às disposições constantes do Contrato Social.

Parágrafo Segundo:

O presente Acordo terá finalidade e usabilidade em face do Contrato Social da empresa **ANEST** servindo de complemento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS PARTICIPAÇOES SOCIETÁRIAS

O capital Social da Sociedade, a ser totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional será de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), dividido em 175.000 cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, distribuídas entre os sócios de forma igualitária em 5.000 (cinco mil) cotas.

Parágrafo Primeiro:

A participação de cada sócio no patrimônio da sociedade se dará de acordo com o valor proporcional integralizado pelo mesmo.

Além do valor integralizado no capital social, cada novo sócio deverá disponibilizar a sociedade em sua conta corrente quantia correspondente a 66,61 salários-mínimos vigentes a época de seu ingresso. A forma de pagamento será avaliada e aprovada em Assembleia Geral.

Parágrafo Segundo:

No tocante a eventuais entradas de novos sócios fica acordado, desde já, que o processo de distribuição societária seguirá as seguintes considerações:

I - No primeiro processo de investimento/entrada de novo(s) sócio(s) no quadro societário da empresa, a distribuição societária se dará em atenção a dedução proporcional e igualitária no que tange os percentuais dos sócios;

II - Havendo o ingresso de novo sócio(s) no quadro societário da empresa após a primeira atualização no quadro societário, haverá a dedução proporcional e igualitária entre os percentuais societários de todos aqueles que presentes no escopo societário da empresa.

Parágrafo Terceiro:

Os Sócios concordam e reconhecem ainda que qualquer violação das cláusulas dispostas neste Acordo entre Sócios, seja pela forma direta em relação à Sociedade e/ou indiretamente, ou por qualquer Pessoa Relacionada sob sua responsabilidade, será considerada uma violação pela própria Sociedade, podendo dar ensejo às medidas judiciais necessárias bem como a deliberação quanto à efetividade e manutenção da sua quota quanto a Sociedade;

Parágrafo Quarto:

Os Sócios declaram e garantem que aceitaram a política de confidencialidade da Sociedade;

Parágrafo Quinto:

Os sócios, desde já, concordam com o direito de exclusão de um ou mais sócios por justa causa, de forma que qualquer sócio que agir indevidamente ou fazer com que a Sociedade haja indevidamente possa ser excluído do quadro societário desta.

Parágrafo Sexto:

Será considerada indevida e fazendo *jus* a exclusão da sociedade a conduta de um sócio que resulte em ato ilegal em relação às suas atividades na empresa, tais como atos ilícitos penais e civis que causem prejuízo direto ao patrimônio da sociedade, como decisões que possam prejudicar o desenvolvimento da atividade empresarial, por exemplo:

(i) atitudes que prejudiquem o direito sobre a propriedade intelectual da sociedade;

(ii) fraudes;

(iii) desrespeito a qualquer regra ou obrigação constante neste Acordo de Sócios;

(iv) desvios e apropriações indébitas de valores financeiros;

(v) assédio moral ou sexual contra colega ou pacientes;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES INDIVIDUAIS

No que se refere às obrigações da **ANEST**, fica definido que todas as partes serão responsáveis pelo bom andamento e gestão do negócio, ficando todos responsáveis pela administração em termos gerais.

Parágrafo Primeiro:

Em que pese o caráter de execução individual das atividades supracitadas, constituir-se-á responsabilidade solidária frente aos resultados e efeitos colaterais advindos destas em atenção ao artigo 1.052 do Código Civil de 2002;

Parágrafo Segundo:

Frisa-se que as atividades a serem exercidas pelas partes não ficarão adstritas apenas àquelas elencadas no Preâmbulo e Cláusula Primeira, devendo haver participação mútua a fim do bom relacionamento e desenvolvimento do negócio em atenção à boa-fé objetiva.

Parágrafo Terceiro:

Além das obrigações acima elencadas, são obrigações individuais de cada um dos sócios cotistas:

(i) Possuir registro de especialista no CREMESC;

(ii) Procurar aperfeiçoamento médico constante;

(iii) Chegar antecipadamente ao local de trabalho escalado a fim de agilizar o procedimento anestésico para que os atos cirúrgicos possam iniciar na hora designada;

(iv) Cumprir as normas do Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Anestesiologia para o exercício profissional e segurança do ato anestésico;

(v) Manter em seu ambiente de trabalho conduta discreta, impessoal, respeitadora dos colegas de profissão e profissionais da área da saúde, contribuindo para valorização da especialidade de anestesiologia.

CLÁUSULA QUARTA – DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE OS SÓCIOS

Em caso de eventual ingresso de novo sócios na empresa em questão, a contar da data de assinatura deste documento, será constituído Termo Aditivo entre as partes envolvidas, em atenção irrestrita ao conteúdo deste Acordo bem como outras Cláusulas e disposições usualmente utilizadas em operações deste gênero, observando a legislação vigente.

Parágrafo Primeiro:

Para ingresso de novo sócio, dever-se-á ter aprovação dos sócios, além de um período probatório de 1 (um) ano para admissibilidade, subscrição e integralização das cotas sociais.

O período probatório servirá como análise técnica e de relacionamento profissional, apreciados pelos demais componentes da Sociedade

Parágrafo Segundo:

A admissão de um novo sócio será realizada quando a demanda de trabalho for muito superior ao número de profissionais atuais constantes do quadro societário e/ou para substituição de um membro constante da própria Sociedade, caso ocorra afastamento, aposentadoria, exclusão ou retirada do sócio.

Parágrafo Terceiro:

A admissão de novo sócio respeitará a divisão de honorários estabelecida por Assembleia Geral, conquanto, iniciará com o percentual de 40% no primeiro ano de

integração na sociedade, 50% no segundo ano, 60% no terceiro ano, 70% no quarto ano, 75% no quinto ano, 80% no sexto ano, 85% no sétimo ano, 90% no oitavo ano, e, no nono ano perceberá o percentual de 100% do rendimento.

Caso o sócio obtenha o Título Superior em Anestesiologia e caso esteja no período aquisitivo da remuneração integral, obterá 10% (dez por cento) de ascensão.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

Acordam as partes que, em se tratando da administração da sociedade, Adriano Dall Magro figurará como sócio administrador vestido do poder de gestão em respeito ao teor do artigo 1.060 do Código Civil de 2002.

Parágrafo Primeiro:

A cada 4 (anos) anos, os cotistas em Assembleia Geral elegerão o socio administrador para gerir a Sociedade.

Parágrafo Segundo:

Frisa-se que a administração da empresa em face dos novos sócios que porventura vierem a integrar o quadro societário após a assinatura do presente documento poderá ser alterada em Termo Aditivo a este Acordo ou ao Contrato Social, em atenção ao artigo 1.060, parágrafo único[1] do Código Civil de 2002;

CLÁUSULA QUINTA: ESCALA DE TRABALHO DELIBERADA E HONORÁRIOS

Pactuam os sócios através desta Cláusula e seus parágrafos o regramento para as escalas de trabalho para realização de suas atividades médicas perante nosocômios e contratantes de serviços da ANEST, culminando com a percepção de honorários pelos serviços prestados.

[1] *Art. 1.060 (...)*
Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade.

As regras gerais da escala diurna, noturna e finais de semana, férias e plantões estão dispostas na sua integralidade no ANEXO I – REGRAS DE ESCALAÇÃO.

Parágrafo Primeiro:

Durantes os turnos matutinos e vespertinos os sócios da ANEST serão indicados para o trabalho conforme escala numérica rotativa. Esta escala será formada através de sorteio pré-definido pelos sócios de forma que os subgrupos mantenham rotatividade dos colegas.

A escala é realizada sempre pelo primeiro plantão do Turno correspondente em cada nosocômio.

Parágrafo Segundo:

A escala para trabalho, ainda, respeitará a seguinte divisão de trabalho:

TURNO MATUTINO e VESPERTINO: os sócios serão indicados de forma igualitária;

TURNO NOTURNO: todos os sócios realizarão plantões noturno, conquanto, serão distribuídos respeitando a ordem cronológica de admissão na Sociedade, sendo os detalhes definidos em Assembleia Geral, conforme as necessidades do serviço.

FINAIS DE SEMANA: será adotado o sistema proporcional decrescente, conforme ordem cronológica de admissão na Sociedade, sendo os detalhes definidos em Assembleia Geral conforme necessidade dos serviços.

Parágrafo Terceiro:

Durante o período probatório, o interessado no ingresso na Sociedade poderá participar das Assembleias Gerais e Extraordinárias, conquanto, não terão direito a voto.

Parágrafo Quarto:

Durante os 3 primeiros meses do período probatório, é proibida a realização de plantões em substituição a outros colegas e/ou sócios da ANEST, sob pretexto de perceber remuneração extra.

Parágrafo Quinto:

O Hospital Unimed Chapecó exige plantão presencial de 24h nos 7 dias da semana, divididos nos Turnos Matutinos, Vespertino e Noturno e Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA), conforme determinado em Assembleia Geral.

Parágrafo Sexta:

Os plantões noturnos semanais, matutinos, vespertinos e noturnos de finais de semana, independentemente da posição que ocuparem na escala de trabalho, serão remunerados, de acordo com o que a Assembleia Geral definir.

Caberá, ainda, a esta Assembleia Geral definir além da remuneração, eventual acréscimo ou supressão desta mesma remuneração.

Os novos sócios da ANEST, mesmo recebendo o percentual de honorários escalonados de ascensão, constantes no Parágrafo Terceiro, da Cláusula Quarta, deste instrumento, terão direito a receber o valor integral da remuneração ajustada neste Parágrafo.

CLÁUSULA SEXTA: PERÍODO DE DESCANSO DENOMINADO FÉRIAS

Apesar de tratar-se de Acordo de Sócios de uma Sociedade Empresária, inexistindo direitos laborais, entendem os Sócios fazerem *jus* a férias, devido as atividades exercidas e seus horários escalonados, conquanto, de forma regrada, conforme elencado nesta Cláusula e devidamente chancelada por Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro:

O gozo do descanso anual (deve ser usufruída em ano corrente), não acumuláveis para períodos subsequentes, serão distribuídos da seguinte forma:

(i) Sócios que ingressaram na Sociedade em período inferior a 1 ano → 1 semana (5 dias úteis);

(ii) Sócios que ingressaram na Sociedade em período inferior a 4 anos → 4 semanas (20 dias úteis);

(iii) Sócios que ingressaram na Sociedade em período superior a 4 anos → 6 semanas (30 dias úteis);

Parágrafo Segundo:

Será permitido a antecipação das férias do ano subsequente, desde que aprovado pelo sócio coordenador de escalas. Os dias antecipados serão devidamente descontados das férias subsequentes e o saldo de dias remanescentes deverá ser obrigatoriamente usufruído, sem possibilidade de nova antecipação.

Parágrafo Terceiro:

O 1º Semestre, para fins de férias, será considerado os meses de janeiro a junho.
O 2º Semestre, será considerado de julho a dezembro.

Parágrafo Quarto:

As férias serão agendadas no aplicativo PEGA PLANTÃO, conforme as necessidades individuais de cada sócio, sem sobrecarregar a escala de trabalho do serviço, respeitando a distribuição aprovada em Assembleia Geral Ordinária:

a) 3 semanas em cada semestre, sendo 2 semanas inteiras e 1 semana fracionada.
b) Duas sextas isoladas por semestre;
c) Marcação dos dias isolados somente após a marcação das semanas inteiras.

Parágrafo Quinto:

É considerado período especial de férias os meses de janeiro e julho. Para estes meses específicos terão prioridades para marcação das férias os Sócios que possuem filhos em idade escolar (ensino fundamental).
Ressalva-se que nestes meses há possibilidade de marcação de férias de tão somente 2 semanas, salvo situações especiais, aprovadas por Assembleia Geral.

Parágrafo Sexto:

Em períodos especiais, como Congressos (COPA e CBA), não será permitida a marcação de férias por nenhum dos sócios, que inclusive estarão previamente marcados no cronograma de escalas.

Nestes períodos somente poderão excluir-se da escala de trabalho os sócios que efetivamente participarão dos Congressos.

Em casos muito específicos e que o número de sócios inscritos nos Congressos for menor que 5, o sócio poderá marcar férias, desde que aprovado pelo Coordenador da escala.

Parágrafo Sétimo:

O sócio que eventualmente tiver que sair da escala em situação de "emergência" poderá fazê-lo, desde que comunicado ao Coordenador da Escala. Nesta situação, automaticamente serão computados os dias de ausência como férias, salvo as situações específicas delineadas na Cláusula Oitava e aprovadas em Assembleia Geral.

Parágrafo Oitavo:

O sócio que necessitar se ausentar do trabalho por qualquer motivo descrito na Cláusula Oitava do presente acordo terá reduzido o número de dias de férias de forma proporcional ao tempo de afastamento utilizado.

a) Sócios com ingresso na sociedade por mais de 4 anos: a cada 30 dias de afastamento, extrai-se 2 dias e meio do período de férias;
b) Sócios com ingresso na sociedade até 4 anos: a cada 30 dias de afastamento, extrai-se 1 dia e meio do período de férias.

Parágrafo Nono:

O sócio que descomprimir alguma disposição desta Cláusula incorrerá em penalidade ora pactuada na perda de dia de descanso (férias), ou seja, para cada dia de descanso utilizado indevida ou irregularmente, perderá um dia de descanso futuro.

CLÁUSULA SÉTIMA: PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS E JORNADAS

Cada Sócio terá direito a 2 dias não computados como descanso (férias) para participação em Congresso Brasileiro de Anestesia e Jornadas Regionais.

Parágrafo Primeiro:
O número máximo de sócios liberados para o Congresso Brasileiro e Congresso Paulistas de Anestesiologia é de 5.

Parágrafo Segundo:
Durante os períodos de Congressos nenhum sócio pode marcar férias, salvo quando não se completar as 5 vagas disponíveis para os Congressos.

Parágrafo Terceiro:
Será observado um rodízio entre os Sócios, para que todos possam participar de eventos científicos em anos subsequentes.

Parágrafo Quarto:
No primeiro ano de ingresso no quadro de cotistas, o novo Sócio não terá o direito ao benefício de ausentar-se por 2 dias para participação em congressos e Jornadas, sendo permitido a este somente a realização de provas para o Título Superior de Anestesiologia (TSA).

CLÁUSULA OITAVA: AFASTAMENTO DO SÓCIO DAS ATIVIDADES MÉDICAS
Por tratar-se o Sócio de profissional liberal da área da saúde, com carga energética e emocional considerável, estando passível igualmente em determinado período de adoentar-se e ter que ficar afastado de suas atividades cotidianas por motivo de doença, razão pela qual importante este instrumento regulamentar tal peculiaridade.

Parágrafo Primeiro:
O Sócio possui o direito de se afastar do serviço por motivo de doença ou invalidez temporária pelo prazo máximo de 12 meses, percebendo neste período uma

contraprestação de 30% da cotação máxima vigente no período a fim de lhe resguardar o sustento e de sua família.

Inclusos nesta situação o afastamento para realização de cirurgias eletivas ou de urgência, excetuando-se aquelas de propósito estético, onde deverá ser utilizado o período de férias. As cirurgias eletivas deverão ser marcadas após o parecer favorável do Departamento Técnico (Coordenador de Escalas), para não comprometer a escala de trabalho.

Após o término do período de afastamento, o Sócio reassumirá o exercício regular de suas atividades profissionais. O retorno também poderá ocorrer nas seguintes condições:

I – no regime de consultório fixo, com direito à percepção de 60% (sessenta por cento) da respectiva produção; ou

II – no regime de meio turno, conforme a organização interna do grupo, com direito à percepção de 50% (cinquenta por cento) da produção correspondente.

Parágrafo Segundo:

Na impossibilidade de retorno do afastamento mencionado no Parágrafo antecedente, será realizada Assembleia Geral Extraordinária para discussão e análise do caso específico do Sócio,

Tal procedimento respeitará aviso de 10 dias de antecedência para convocação de todos os sócios, definindo data, hora e local.

Parágrafo Terceiro:

O afastamento para realização de exames eletivos e consultas médicas e outras deverão ser realizados com a utilização dos dias de férias/descanso.

Parágrafo Quarto:

Caso necessite o sócio acompanhar um familiar direto (esposo/esposa, filhos, pais e/ou irmãos) por motivo de doença GRAVE, terá direito afastar-se por até 12 meses (podendo utilizar de forma intercalada), recebendo 30% da cota máxima vigente, deduzidos os valores dos plantões e cotas de participação em trabalho noturno.

Após o período de afastamento o sócio deve retornar a exercer suas atividades normalmente.

Caso esteja impossibilitado de retorno, o mesmo deixará de perceber a contraprestação discriminada acima e uma Assembleia Geral Extraordinária será convocada para tratar do caso específico.

Quando houver vínculo familiar entre alguns dos sócios da ANEST, somente um deles poderá usufruir do benefício concedido neste Parágrafo.

Parágrafo Quinto:

Cada Sócio terá o direito de usufruir de afastamento, descanso e recuperação em caso de falecimento de familiar direto (esposo/esposa, filhos, pais e/ou irmãos) por até 7 dias corridos, sem prejuízo de seus rendimentos e direito a férias.

Parágrafo Sexto:

Casa sócio poderá solicitar afastamento por motivos pessoais por tempo determinado e sem direito a perceber qualquer contraprestação ou rendimento, que deverá ser deliberado por Assembleia Geral, podendo ou não, ser aprovado.

Parágrafo Sétimo:

Será concedido a sócia gestante um período de 120 dias corridos de afastamento, fazendo *jus* a perceber 30% da cota máxima vigente de honorários no período.

Respectivo período pode ser majorado, desde que pleiteado pela sócia e devidamente aprovado por Assembleia Geral, ficando ressalvado que, aprovado a majoração do afastamento, nada perceberá neste período a título de rendimento/contraprestação.

Após o término do período de afastamento, a Sócia reassumirá o exercício regular de suas atividades profissionais. O retorno também poderá ocorrer nas seguintes condições:

I – no regime de consultório fixo, com direito à percepção de 60% (sessenta por cento) da respectiva produção; ou

II – no regime de meio turno, conforme a organização interna do grupo, com direito à percepção de 50% (cinquenta por cento) da produção correspondente.

Parágrafo Oitavo:

Há também necessidade de regulamentar caso algum sócio necessite se afastar em condições pontuais e especificas, entre as quais:

a) **Drogadição:** o sócio que estiver em uso vicioso de drogas (anestésicas ou não), será imediatamente excluído do quadro de sócios da ANEST, sem qualquer direito de indenização e/ou ônus a Sociedade Empresária;
Fará apenas jus o Sócio excluído a perceber sua cota social pelo valor nominal consignado no Contrato Social ou Alteração Contratual e cota parte do fundo de aplicação mantido pela Sociedade Empresária.

Parágrafo Nono:

Cada integrante da ANEST deve, ao atingir a idade de **70 anos**, assumir posição de escala de meio turno (50%) com contraprestação/honorários adequados para a faixa em que se encontra

Parágrafo Décimo:

Cada integrante da ANEST deve, ao atingir a idade de **75 anos,** solicitar obrigatoriamente sua saída da Sociedade;

Parágrafo Décimo Primeiro:

O sócio que completar 30 anos de ingresso no quadro societário da Sociedade e/ou atingindo a idade limite de 70 anos, em se afastando em definitivo da mesma, receberá por 12 meses, o valor correspondente a 25% dos honorários vigentes, acrescidos de 1% por ano trabalhado após os 30 anos, deduzidos os valores dos plantões e cotas de participação em trabalho noturno. Perceberá, igualmente, sua cota social pelo valor nominal consignado no Contrato Social ou Alteração Contratual e cota parte do fundo de aplicação mantido pela Sociedade Empresária.

Parágrafo Décimo Segundo:

O sócio que optar por regime de meio turno anteriormente a completar 25 anos de ingresso no quadro societário da Sociedade, no momento em que atender a condição exposta no Parágrafo Décimo Segundo, receberá por 12 meses, o valor correspondente a 15% acrescidos de 1% por ano trabalhado após 30 anos.

CLÁUSULA NONA: BENEFÍCIOS POR TEMPO DE SERVIÇO

Os sócios pelo lapso temporal de ingresso na Sociedade terão benefícios, quais discriminados nos Parágrafos subsequentes:

Parágrafo Primeiro:

O sócio da ANEST ao atingir cota de 100% (9 anos) no quadro societário poderá de forma opcional executar suas atividades em meio turno, o qual será regulamentado por este Acordo de Sócios e alterado em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com a necessidade das atividades empresariais.

Parágrafo Segundo:

OPÇÃO 1: MEIO TURNO (DOIS COLEGAS DIVIDINDO UM NÚMERO)

1. Do Direito ao Benefício

O regime de meio turno constitui benefício concedido aos sócios que preencham os seguintes requisitos:

a) Tempo mínimo de 10 (dez) anos de participação no grupo;

b) Idade entre 70 (setenta) e 75 (setenta e cinco) anos, sendo a adoção deste regime obrigatória a partir dos 75 (setenta e cinco) anos de idade.

2. Regime Diurno

a) A escala diurna compreenderá os turnos da manhã e da tarde.

b) Os profissionais dividirão os plantões de forma a assegurar igualdade de tempo de trabalho e de folgas, mediante acordo mútuo entre ambos.

c) A escala permanecerá vinculada a um único número, mantida de forma inalterada.

3. Regime Noturno

a) Será mantido o número de plantões correspondente ao sócio mais novo ou àquele que possua o maior número de plantões, conforme aplicável.

4. Remuneração

A remuneração corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor integral atribuído ao número.

5. Férias

Serão concedidos 30 (trinta) dias de férias ao número, sendo a divisão ajustada entre os colegas, conforme acordo.

6. Retorno à Cota Integral

O retorno à cota integral (100%) poderá ocorrer após o cumprimento de, no mínimo, 2 (dois) anos de vigência desta modalidade, e desde que haja necessidade do grupo.

O sócio que permanecer exercerá suas atividades em **meio turno isolado**, matutino ou vespertino.

7. Feriados e Recessos Anuais

A participação nos plantões de feriado e recesso anual será mantida em 50% (cinquenta por cento).

8. Direito a Voto

O número manterá direito integral a voto nas deliberações do grupo.

9. Ações e Multas

A responsabilidade por eventuais ações e multas será igualmente dividida, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada colega.

10. Afastamento por Doença

Em caso de afastamento por motivo de doença de um dos colegas, o outro

assumirá integralmente o turno correspondente ao meio turno isolado, seja da manhã ou da tarde.

OPÇÃO 2: MEIO TURNO (UM COLEGA EM TURNO ISOLADO)

1. Escala Diurna

a) O regime diurno será exercido nos seguintes horários: das 07h00 às 13h00 (turno da manhã) e das 13h00 às 19h00 (turno da tarde).

b) O sócio assumirá a escala na posição correspondente entre o primeiro e o quarto turno de cada período, conforme a ordem previamente estabelecida na escala geral.

2. Regime Noturno

Será mantido o número de plantões originalmente atribuídos ao sócio, observadas as disposições internas do grupo.

3. Remuneração

A remuneração do sócio nesta modalidade corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor integral da cota ou número.

4. Férias

Serão assegurados 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com o número ou cota compartilhada.

5. Feriados e Recessos Anuais

A participação em plantões durante feriados e recessos anuais será mantida em 50% (cinquenta por cento).

6. Direito a Voto

O sócio manterá direito integral a voto nas deliberações e assembleias do grupo.

7. Ações e Multas

As responsabilidades decorrentes de ações, penalidades ou multas serão mantidas na proporção de 50% (cinquenta por cento).

8. Afastamento por Doença

Em caso de afastamento por motivo de saúde, aplicar-se-á o disposto no Regimento Interno do grupo, observando-se as normas de substituição e compensação vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A ANEST poderá criar e manter um fundo de aplicação em instituição bancária de sua escolha.

Parágrafo Primeiro:

O Fundo deve ser igualitário e proporcional entre os integrantes da ANEST.

Parágrafo Segundo:

Os valores serão determinados pela ANEST e depositados mensalmente, por tempo indeterminado, até que, em Assembleia, resolva dividir os valores de forma proporcional ou definir novas formas de aplicação.

Parágrafo Terceiro:

Qualquer movimentação do Fundo só poderá ser realizada pelo departamento financeiro da ANEST, com a concordância de todos os sócios em Assembleia Geral,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PATRIMÔNIO DA ANEST

O patrimônio da ANEST é constituído por todos seus bens móveis e imóveis, adquiridos durante a sua existência:

I – Equipamentos médicos ou não, adquiridos para a realização de procedimentos anestésicos;

II – Eletrodomésticos;

III – Consultório, constituído por imóvel próprio, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 300E, salas 310/311, Policlínica Santo Antônio, Centro, Chapecó, SC;
IV – Veículo próprio;
V – Investimentos imobiliários.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADE CIVIL E MÉDICO-LEGAL

Todo integrante da Sociedade responderá por seus atos, devendo tratar as possíveis complicações advindas de procedimento anestésico por ele realizado.

Parágrafo Primeiro:

A ANEST conta com assessoria jurídica, conforme contrato de prestação de serviços jurídicos vigente, a qual auxiliará o Sócio em suas defesas na esfera administrativa e judicial.

Parágrafo Segundo:

Caso a decisão do processo administrativo ou judicial seja desfavorável ao Sócio ou for realizado acordo entre médico e paciente, o valor arbitrado/acordado deverá ser dividido igualmente entre Sócio e a ANEST, salvo o que dispõe o Parágrafo Terceiro abaixo.

Parágrafo Terceiro:

A ANEST ficará isenta de arcar com quaisquer custos que advirem de:

1. Atrasos em plantão ou escala normal não justificável;
2. Recusa em tratar e/ou acompanhar complicações de um ato anestésico próprio, mesmo após repetidos alertas;
3. Complicações decorrentes de atos técnicos e/ou comportamentais sem concordância com protocolos da ANEST ou qualquer literatura médica vigente;

Parágrafo Quarto:

Casos específicos e pontuais em que ocorrer dúvida quanto as responsabilidades civis do caso em análise serão discutidas pelos demais Sócios e decididos em Assembleia Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: SANÇÕES

São considerados atos possíveis de punição:

(i) Sobrecarregar os demais sócios da ANEST ou causar mal-estar no campo de trabalho;

(ii) Atuar de forma negligente ou imprudente perante o paciente;

(iii) Demora em atender chamados;

(iv) Deixar o trabalho colocando os demais sócios e pacientes em risco;

(v) Ausentar-se do trabalho sem qualquer justificativa;

(vi) Ausentar-se das reuniões e Assembleias sem qualquer justificativa;

(vii) Atrasos ou qualquer outra atitude que venha alterar ou prejudicar a imagem, reputação ou minorar rendimentos da ANEST;

Parágrafo Primeiro:

As sanções serão as seguintes:

(i) Primeira infração → advertência oral;

(ii) Segunda infração → advertência escrita;

(iii) Terceira infração → multa, com valor prefixado em um plantão de primeiro noturno semanal;

(iv) Quarta infração → perda de 2 a 5 dias de descanso (férias), conforme decisão pelo Comitê de ética;

(v) Quinta infração → multa correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário mensal.

Parágrafo Segundo:

Após reincidências do sócio, será realizada Assembleia Geral para discussão da possibilidade de exclusão do sócio, havendo escrutínio secreto para tal fim.

Parágrafo Terceiro:

Em qualquer situação que ficar comprovada apropriação indébita de recursos provenientes, tanto de atos profissionais, quanto recursos administrativos, o sócio que estiver envolvido será excluído da sociedade de forma sumária, cabendo neste caso, perceber o valor correspondente a sua cota social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E COMITÊS INTERNOS

A ANEST será formada por Comitês formados em Assembleia Geral por meio de votação ou aclamação.

Parágrafo Primeiro:

Ficam instituídos 08 (oito) Comitês de Gestão, a saber: Comitê de Ética e Conduta, Comitê Executivo de Gestão, Comitê de Gestão de Pessoas, Comitê Financeiro, Comitê de Qualidade, Comitê de Escalas, Comitê de Educação Continuada e Residência Médica e Comitê de Tecnologia e Materiais. Cada Comitê possui finalidade específica, subordinação hierárquica própria, composição definida, competências e responsabilidades determinadas, bem como regramento próprio quanto à realização de reuniões, deliberações e encaminhamentos. Os Comitês exercerão suas atividades em conformidade com os princípios éticos e de governança corporativa, observando sempre a transparência, a integridade e a responsabilidade institucional. A estrutura, composição e atribuições de cada Comitê encontram-se detalhadas no ANEXO II deste Regimento, parte integrante e indissociável do presente instrumento.

Parágrafo Segundo:

A constituição dos Coordenadores será definida a cada 4 anos. Havendo concordância entre os Sócios, tal prazo poderá se prorrogar.

Os sócios com 9 anos ou mais de ingresso na sociedade poderão assumir a os cargos de Responsável Técnico, Coordenador Financeiro e Coordenador Geral.

Parágrafo Terceiro:

Ficam estabelecidos como remunerados, de forma obrigatória, os cargos de Coordenador Geral e Coordenador Financeiro. Os demais cargos de coordenação de comitês, bem como funções de natureza operacional, poderão, a critério do grupo, perceber remuneração, desde que haja deliberação favorável em Assembleia Geral, com aprovação mínima de dois terços (2/3) dos votos dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ASSEMBLEIA GERAL

Será realizada mensalmente uma Assembleia Geral Ordinária, designada sempre para um dia específico dentro da primeira quinzena do mês.

A convocação deverá ser para todos os sócios e com antecedência mínima de 5 dias úteis, especificando os assuntos que serão abordados na solenidade.

Todos os sócios concordam que a convocação poderá ser feita por meios eletrônicos (e-mail, WhatsApp individual ou grupo).

A deliberação será devidamente anotada e registrada em Ata.

Parágrafo Primeiro:

A presença na Assembleia Geral é obrigatória e a ausência injustificada será punida com multa no valor de R$ 600,00.

Parágrafo Segundo:

Serão considerados motivos para ausência na Assembleia Geral: férias, plantão, dia de aniversário, afastamentos permitidos no regimento.

Parágrafo Terceiro:

Caberá ao Coordenador Geral ser responsável pela avaliação da possibilidade e remarcação de datas das Assembleias Gerais, de acordo com o número de colegas de impossibilitados de participar das mesmas.

Caso seja necessária a redesignação da Assembleia Geral Ordinária, a mesma deverá respeitar aviso de antecedência da nova data de 5 dias úteis.

Parágrafo Quarto:

As Assembleias Gerais Extraordinárias serão marcadas conforme a urgência da pauta que deve ser definida e obrigatoriamente informada a todos os sócios com 48 horas de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TRABALHO E REMUNERACAO EXTRA SOCIEDADE

Sócio da ANEST não poderá exercer atividade de anestesia remunerada ou não em qualquer instituição vinculada previamente com a sociedade empresária em Chapecó e região.

Parágrafo Primeiro:

Caso algum sócio exerça atividade nestas condições, evidenciando concorrência ilegal e desleal, tal fato deve ser apurado pelo Coordenador Geral, incumbindo da aplicabilidade de alguma sanção disposta neste Acordo de Sócios.

Parágrafo Segundo:

Caso o sócio insista em realizar trabalho extra na função de anestesista, configurada a concorrência desleal e ilegal, caberá ao Coordenador Geral levar a conhecimento dos demais sócios em Assembleia Geral a fim de deliberar a melhor penalidade a ser aplicada aquele.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ALTERAÇÕES DO ACORDO

O presente acordo poderá ser alterado em Assembleia Geral ordinária e/ou Extraordinária a partir do voto favorável de 2/3 dos sócios.

Parágrafo Único:

Qualquer mudança feita neste acordo não será válida se não for feita por escrito e assinada pelas partes integrantes deste.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: PRAZO E VALIDADE

O presente acordo entra em vigor na data em que for assinado e terá prazo indeterminado de validade.

Parágrafo Único:

No caso de eventual conflito entre as disposições do presente acordo e as disposições do contrato social, se resolverão pela prevalência da lei e dos princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: SUCESSÃO

Os sucessores na titularidade da participação societária dos sócios que subscrevem se obrigam ao cumprimento deste acordo e atender o que dispõe a Cláusula 8, Parágrafo Terceiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CONFIDENCIALIDADE

Acordam as partes em manter sigilo sobre as informações trocadas e/ou geradas durante a execução das atividades pertinentes ao escopo de projeto da **CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECÓ LTDA** por um período de 10 anos e ainda, não revelar nem transmitir direta ou indiretamente as informações trocadas a terceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento da atividade objeto deste Acordo.

Parágrafo Primeiro:

Salvo se exigido por qualquer lei aplicável, nenhum anúncio, escrito ou oral, comunicado à imprensa, qualquer outro anúncio público similar ou divulgação privada no que diz respeito às transações contempladas este Acordo será feito para qualquer terceiro, a menos que aprovada conjuntamente por todas as Partes.

Parágrafo Segundo:

Se a divulgação for exigida por qualquer lei aplicável, a Parte divulgadora deverá consultar previamente as outras Partes e tentar, de boa-fé, refletir as preocupações das outras Partes na divulgação exigida. Será considerada como exceção à regra de confidencialidade aqui disposta, anúncio, escrito ou oral, ou a divulgação privada no

que diz respeito às transações contempladas neste Acordo, quando feito pela Sociedade, aos representantes, empregados e colaboradores da Sociedade que tenham necessidade de conhecer tais informações para execução do disposto no presente Acordo.

Parágrafo Terceiro:

Cada Parte, para fins de sigilo, obriga-se por seus administradores, empregados, prepostos, a qualquer título, e comitentes.

Parágrafo Quarto:

O termo "**Informações Confidenciais**" sintetizará todas e quaisquer informações orais, escritas ou em forma eletrônica relacionadas às partes, seus negócios e operações ou projetos revelados ou de qualquer outra maneira tornadas reciprocamente disponíveis, incluindo, porém sem se limitar a:

1. Pesquisa e desenvolvimento;
2. Linhas de produtos (códigos dos aplicativos);
3. Informações relativas ao pessoal e processos de remuneração;
4. Acordos de cooperação;
5. Informações sobre fornecedores;
6. Aspectos financeiros e operacionais;
7. Informações técnicas e científicas;
8. Estrutura;
9. Estratégia comercial e;
10. Informações sobre seus clientes, assim como,

nomes, segredos comerciais e planos de negócios.

Parágrafo Quinto:

Por questões de segurança e tráfego seguro das Informações Confidenciais, as partes acordam em realizar primordialmente a comunicação e o fornecimento de dados e informações por meio de E-mail seguindo padrões de comunicação e protocolos de postagem e recebimento a serem definidos entre as partes.

Parágrafo Sexto:

O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará:

a) na extinção do presente instrumento, se ainda vigente, dentro das formas nele permitida;

b) em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos;

c) adoção dos remédios jurídicos e sanções cabíveis pela legislação pertinente;

Parágrafo Sétimo:

Só serão legítimos como motivos de exceção à obrigatoriedade de sigilo, a ocorrência de descumprimento nas seguintes hipóteses: a) a informação já era conhecida anteriormente às tratativas do negócio jurídico; b) houve prévia e expressa anuência dos Partícipes, quanto à liberação da obrigação de sigilo e confidencialidade; c) a informação foi comprovadamente obtida por outra fonte, de forma legal e legítima, independentemente do presente instrumento jurídico; d) determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, desde que notificada imediatamente a empresa a ser constituída, previamente à liberação, e sendo requerido segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo.

Parágrafo Oitavo:

Qualquer divulgação sobre qualquer aspecto ou informação sobre o presente instrumento está adstrita ao prévio conhecimento da outra Parte, ressalvada a mera informação sobre sua existência ou a divulgação para fins científicos.

Parágrafo Nono:

Fica autorizada a revelação das Informações Confidenciais pelas Partes aos seus administradores, sócios, investidores, assessores legais e financeiros que tenham necessidade de conhecer tais informações Confidenciais para fins de análise de Investimento, observado que tais pessoas deverão ser informadas do caráter sigiloso de tais informações Confidenciais previamente ao seu recebimento e deverão obrigar-se a manter o sigilo correspondente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Acordo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, constituindo obrigações legais, válidas e vinculantes, e os Sócios não poderão ceder transferir ou dispor de qualquer forma dos direitos relacionados a este Acordo, sem autorização prévia e por escrito dos demais Sócios. O Acordo obriga os Sócios e seus sucessores para todos os fins.

Parágrafo Primeiro:

Este Acordo contém o acordo e entendimento integral entre os Sócios e substitui especificamente qualquer entendimento prévio, verbal ou escrito, sobre o projeto objeto deste.

Parágrafo Segundo:

A falha de um ou mais Sócios em insistir no cumprimento de quaisquer termos, convenções ou condições deste Acordo, de exercer quaisquer direitos ou privilégios previstos aqui, ou a renúncia por qualquer das Partes com relação à violação de quaisquer termos, obrigações ou condições deste Acordo, não deve ser interpretada como uma renúncia a quaisquer termos, obrigações, condições, direitos ou

privilégios, sendo certo que estes deverão continuar e permanecer em pleno vigor e efeito como se nenhuma tolerância ou renúncia houvesse ocorrido.

Parágrafo Terceiro:
Na hipótese de qualquer das disposições previstas neste Acordo ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em pleno vigor desde que a substância econômica ou jurídica das transações aqui contempladas não seja afetada de maneira adversa para qualquer das Partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste Acordo de Sócios.

Estando assim justas e contratadas, as partes firmam o presente acordo, firmado em 4 (quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, ficando cada acordante com uma via, arquivando-se uma via na sede social.

Chapecó, SC, 14 de outubro de 2025.

MARCOS TADEU CURY CPF: 497.678.526-20	**RAUL PERIZZOLO** CPF: 385.722.909-82
ADRIANO DALL MAGRO CPF: 540.770.360-20	**VICENTE ANTONIO ALVES PONS** CPF: 494.407.480-87

MAURICIO MAHALEM BASTOS
CPF: 688.191.456-34

_____

ROSEMARY CURY
CPF: 524.964.736-72

_____

HUMBERTO HEPP
CPF: 023.133.559-85

_____

RODNEI CABRAL LIMA
CPF: 001.782.986-03

_____

MARCOS CARDOSO COSTA
CPF: 000.955.520-06

_____

RAQUEL SCHNEIDER FELICIANI
CPF: 968.721.790-15

_____

ALINE BOFF BONFANTE
CPF: 004.659.690-97

_____

GUSTAVO ALMANSA GARIM
CPF: 712.476.370-34

_____

OSCAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
CPF: 013.261.266- 60

_____

JANAINA SANCHES FAVORITO MORAIS
CPF: 298.366.108-39

_____

DIEGO BONIATTI RIGOTTI
CPF: 041.606.429-93

_____

FERNANDA GUOLLO
CPF: 017.930.270-13

_____

GABRIELA CITRON VEDANA
CPF: 065.486.889-10

GUSTAVO BIESDORF

CPF: 057.232.639-43

ROBERTA MARINA GRANDO

CPF: 052.832.279-60

LEONARDO FERRAZZO

CPF: 074.371.679-56

MARILIO JOSÉ FLACH

CPF: 001.663.930-88

FERNANDO HENRIQUE MACHADO

CPF: 020.230.620-80

JOÃO RICARDO MOREIRA

LEANDRO BERNARDES

CPF: 076.844.089-09

CRISTINA BERTOL BARBOSA

CPF: 069.378.829-12

TIAGO IOP VIANA

CPF: 040.202.859-77

GUILHERME SOUZA MELO

CPF: 025.336.589-95

GUILHERME JONCK STAUB

CPF: 049.000.369-94

PAULO TONINI

CPF: 057.901.109-75

CPF: 075.925.109-60

_____

ALEXANDRE SILVA DANIELI

CPF: 979.119.500-59

_____

ALEXANDRE SCHMIDT

CPF: 819.920.680-20

_____

EDUARDO SCHMIDT SAVOLDI

CPF: 087.759.129-61

_____

GIOVANA GOMES NOLL

CPF: 027.542.000-02

_____

KLISMAN DRESCHER HILLESHEIN

CPF: 079.700.949-37

_____

MATHEUS LEMOS VIEIRA DA CUNHA

CPF: 052.482.859-84

_____

LOUISE MACAGNAN WARNAVA

CPF: 057.504.069-6

_____

KARINE BEDIN CPF: 036.397.560-88

_____

THAYNA REGINA SANTOS

CPF: 093.390.859-81

_____

ERLEI PERINI

CPF: 006.420.760-90

_____

GABRIEL JUAN KETTENHUBER COSTA

CPF: 029.613.660-38

_____

RAFAEL PELISSARO

CPF: 060.561.929-89

ANEXO I – REGRAS DE ESCALA, TURNOS, FÉRIAS E PLANTÕES

1. ORGANIZAÇÃO DOS TURNOS E ESCALAS

1.1. Os turnos de trabalho serão divididos nos seguintes horários: das 07h30 às 13h30 e das 13h30 às 19h00, entre os profissionais integrantes do grupo.
1.2. A escala de trabalho será elaborada com base em numeração rotativa, devendo ser revisada e atualizada a cada quatro (4) meses.
1.3. A designação para as cirurgias será realizada conforme a ordem estabelecida na escala do respectivo turno, sendo preferencialmente escalados os primeiros colegas nas cirurgias de maior complexidade e/ou duração, observando-se a necessidade operacional e o fluxo dinâmico de entrada de procedimentos.
1.4. Os últimos colegas escalados deverão atuar preferencialmente em cirurgias de menor complexidade e/ou curta duração.
1.5. As compensações decorrentes de ausências por motivo de férias ou licença serão realizadas sempre que o número de profissionais disponíveis em determinado turno, em cada hospital, for superior a uma (1) unidade de diferença, buscando-se a equivalência entre os grupos.
1.6. As trocas e compensações ocorrerão entre posições de função equivalente, não sendo possível assegurar igualdade absoluta entre os turnos. O substituto deverá permanecer até as 19h00 no respectivo hospital (ainda que liberado antes), retornando posteriormente à sua posição original, observada eventual necessidade de remanejamento entre instituições.
1.7. As ajudas entre hospitais (remanejamentos pontuais) serão as primeiras a serem liberadas em cada turno. Caso seja necessária a convocação de profissional do outro turno, deverá ser considerada a instituição que está sendo auxiliada (maior número de postos de trabalho), chamando-se o colega plantonista do mesmo hospital do turno oposto.
1.8. Na hipótese de ausência de cirurgias no Hospital da Criança, os profissionais ali designados poderão ser realocados para auxílio em outros hospitais, antes da convocação dos plantonistas do turno oposto.

A ordem de prioridade para ajudas obedecerá à seguinte sequência:
(I) entre hospitais (HRO e Unimed);
(II) colegas não escalados do Hospital Materno;
(III) colegas não escalados do consultório;
(IV) plantonistas do turno oposto.

1.9. Nos feriados, o grupo será dividido em duas (2) partes, sendo que uma metade gozará folga. Em caso de afastamentos, o dia correspondente deverá ser trocado, ressalvadas apenas situações emergenciais nas quais não haja tempo hábil para substituição.
1.10. Para o recesso de final de ano, o grupo será igualmente dividido em duas (2) partes, de modo que uma usufruirá folga nos dias peri-natalinos e a outra nos dias peri-reveillon.

2. CONSULTÓRIO

2.1. Quando o número de consultas agendadas ultrapassar quarenta e duas (42), será designado um profissional de apoio, desde que haja consultório disponível.
2.2. O profissional de apoio será responsável pelo atendimento excedente, limitado a quinze (15) pacientes, devendo atender mínimo de sete (7).

3. FÉRIAS

3.1. Os agendamentos serão realizados pelo aplicativo Pega Plantão, conforme decisão individual de cada integrante.

3.2. Os dias de férias são contados em dias úteis e deverão ser usufruídos no mesmo exercício, sendo vedado o acúmulo para o ano seguinte.
3.3. Serão disponibilizadas seis (6) vagas diárias para férias. Em situações excepcionais, poderá ser aberta uma sétima vaga, a qual equivalerá a três (3) dias de férias.
3.4. Na semana anterior e posterior ao recesso de final de ano, não será permitida a utilização da sétima vaga, exceto em caso de licença-saúde.

3.5. Poderá haver adiantamento de dias de férias referentes ao exercício subsequente, mediante aprovação do coordenador de escalas. Tais dias serão descontados no período correspondente, sendo vedada nova antecipação no exercício posterior.
3.6. Após 25 (vinte e cinco) anos de participação no grupo, será concedido 1 (um) dia adicional por ano, até o limite máximo de 35 (trinta e cinco) dias úteis.
3.7. É obrigatório o gozo de metade dos dias de férias até o final de junho (para profissionais sem filhos em idade escolar) ou julho (para profissionais com filhos em idade escolar – ensino fundamental e médio). Dias não usufruídos dentro desses prazos serão perdidos.

3.8. Penalidades: o descumprimento das regras previstas neste Anexo acarretará a perda de dias de férias, sendo descontado um (1) dia de férias para cada dia irregular, podendo o desconto ocorrer no exercício subsequente caso a irregularidade seja constatada após o usufruto total do período anual.

3.9 Prazos e Comunicações:

(I) O pedido de desistência de semanas em meses de alta demanda (janeiro, julho e dezembro) ou em semanas com feriados deverá ser feito com antecedência mínima de 1 (um) mês, sob pena de manutenção da contagem dos dias de férias;
(II). O pedido de agendamento de férias em meses nobres (janeiro, julho, dezembro) ou para participação em congressos deverá ser apresentado com antecedência mínima de 3 (três) meses, sob pena de disponibilização das vagas a outros colegas;

(III) A desmarcação de dias de congresso deverá igualmente ocorrer com antecedência mínima de 3 (três) meses, sob pena de contagem desses dias como férias.

4. PLANTÃO

6.1. Os integrantes do grupo realizarão plantões noturnos e de finais de semana, distribuídos de forma decrescente quanto ao número e complexidade, conforme a ordem cronológica de admissão no grupo.
6.2. As escalas de plantão serão divulgadas no início de cada exercício, após eventual ingresso de novos integrantes.
6.3. Durante os três (3) primeiros meses de participação no grupo, é vedada a realização de plantões extras com finalidade de remuneração adicional.

6.4. No período noturno, os plantões serão compostos por três (3) plantonistas (acrescidos do P4 do Hospital Materno), sendo:

P1: Hospital Regional do Oeste (HRO), das 19h às 07h;

P2: Hospital Unimed, das 19h às 07h;

P3: Auxílio presencial no Hospital Unimed das 19h às 23h e sobreaviso após este horário;

P4: Segundo sobreaviso dos hospitais.

6.5. Nos finais de semana, a escala será composta por quatro (4) plantonistas, responsáveis pela cobertura das 48 horas, além de sete (7) colegas de apoio designados para cirurgias eletivas ou urgências, conforme deliberação em assembleia. O 11º profissional atuará em sobreaviso do Hospital Materno durante as 48 horas.

6.6. A ordem de escalação para o sábado pela manhã obedecerá à seguinte sequência: P1, P2, 7, 8, 5, 6, 11, 9, 10, P3, P4, mantendo-se esta ordem em caso de liberações e novas cirurgias.

6.7. As cirurgias do sábado à tarde seguirão escala corrida, independentemente de serem urgências ou eletivas.

6.8. As cirurgias de urgência no domingo ficarão inicialmente sob responsabilidade dos plantonistas da urgência, sendo posteriormente convocados os plantonistas das eletivas, caso necessário.

6.9. A ordem de liberação dos profissionais será a seguinte: P4/P3, P09, P10, P11, P6, P5, P8, P7, P2/P1.

6.10. A escalação dos turnos subsequentes seguirá as ordens abaixo, respeitando-se a separação entre cirurgias eletivas e urgências:

Sábado à tarde: P.P.6.5.9.10.11.P.P;

Domingo pela manhã: P.P.11.8e.7e.P.P (e = eletivas);

Domingo à tarde: P.P.11.7e.8e.P.P (e = eletivas).

ANEXO II – COMITÊS INTERNOS

A) COMITÊ DE TECNOLOGIA E MATERIAIS

1. Identidade Organizacional

Nosso Negócio

Somos um grupo de anestesiologistas comprometidos com atuação abrangente em todas as áreas da anestesiologia, manejo da dor, cuidados intensivos, ensino e pesquisa.

Nossa Missão

Proporcionar cuidados anestésicos de excelência, garantindo segurança, conforto e bem-estar. Atuamos com inovação e qualificação contínua em ambiente colaborativo e sustentável.

Nossa Visão

Ser reconhecido como centro de excelência em anestesiologia na macrorregião sul, destacando-se pela inovação, qualidade e segurança.

Princípios e Valores

Segurança • Ética • União • Colaboração • Governança • Transparência • Sustentabilidade • Excelência • Inovação • Humanização

Política de Qualidade

Comprometidos com a excelência em anestesiologia, promovemos segurança, qualidade e cuidado humanizado em cada etapa do atendimento.

O Comitê Financeiro fundamenta suas atividades nesses princípios e compromissos institucionais, garantindo que suas decisões financeiras estejam sempre alinhadas à missão e à visão organizacional.

2. Finalidade

O Comitê de Tecnologia e Materiais tem como finalidade planejar, supervisionar e avaliar os processos de aquisição, uso, manutenção e controle de materiais, medicamentos e tecnologias médicas utilizados pelo Serviço de Anestesia.

Seu propósito é promover padronização técnica, segurança do paciente e otimização de recursos, alinhando inovação tecnológica à sustentabilidade financeira e ambiental.

3. Subordinação Hierárquica

De acordo com o organograma institucional, o Comitê de Tecnologia e Materiais:

- Está subordinado ao Coordenador Geral e ao Comitê Executivo de Gestão;
- É coordenado pelo Coordenador de Tecnologia e Materiais, que responde diretamente à Coordenação Geral;
- Atua em articulação com os Comitês de Qualidade, Financeiro e Gestão de Pessoas, garantindo coerência e integração dos processos.

4. Composição

O Comitê é composto por:

- Coordenador de Tecnologia e Materiais – Coordenador do Comitê;
- Membros Técnicos – anestesiologistas, enfermeira do centro cirúrgico e apoio administrativo;

- Convidados – conforme necessidade (engenharia clínica, compras, CCIH ou farmácia hospitalar).

A composição poderá ser revista periodicamente conforme necessidades estratégicas, tecnológicas e operacionais.

5. Competências e Responsabilidades

5.1 Compete ao Comitê de Tecnologia e Materiais:

- Planejar, coordenar e supervisionar o processo de padronização, aquisição e controle de materiais, medicamentos e equipamentos utilizados nas práticas anestésicas;
- Avaliar, selecionar e validar novas tecnologias e equipamentos anestésicos, considerando critérios técnicos, de segurança e custo-benefício;
- Garantir conformidade com as normas da ANVISA, CFM e demais legislações sanitárias vigentes;
- Supervisionar a manutenção preventiva, corretiva e calibração periódica dos equipamentos anestésicos, assegurando rastreabilidade e desempenho adequado;
- Elaborar e revisar protocolos de uso, rastreabilidade, armazenamento e descarte de materiais e medicamentos, conforme requisitos legais e institucionais;
- Avaliar a infraestrutura física e tecnológica dos locais de atuação do Serviço de Anestesia, verificando condições de segurança, ergonomia e viabilidade operacional;
- Apoiar o planejamento financeiro e orçamentário, emitindo pareceres técnicos sobre investimentos, reposições e substituições tecnológicas;
- Conduzir treinamentos e capacitações periódicas sobre o uso seguro de tecnologias, equipamentos e insumos anestésicos;
- Investigar falhas técnicas, eventos adversos e não conformidades relacionadas a materiais ou equipamentos, propondo medidas corretivas e preventivas;
- Assegurar comunicação técnica eficiente entre o Comitê, fornecedores, engenharia clínica, setor de compras e equipe assistencial, promovendo integração e rastreabilidade das decisões.

5.2 Papéis e Responsabilidades dos Integrantes

5.2.1 Coordenador de Tecnologia e Materiais – Coordenador do Comitê

Responsável por liderar tecnicamente as atividades do Comitê, assegurando conformidade, eficiência e rastreabilidade em todas as etapas da gestão de materiais e tecnologias.

Principais atribuições:

- Planejar e supervisionar a padronização e aquisição de materiais e equipamentos;
- Garantir a manutenção e calibração regular dos equipamentos anestésicos;
- Coordenar análises de custo-benefício e emitir pareceres técnicos sobre novas aquisições;
- Validar especificações técnicas de produtos junto à engenharia clínica e ao setor de compras;
- Conduzir reuniões periódicas para avaliação de indicadores e atualização tecnológica;
- Representar o Comitê em auditorias internas e externas;
- Promover capacitação da equipe sobre boas práticas no uso de tecnologias e materiais;
- Garantir a conformidade regulatória e documental dos processos;
- Zelar pela sustentabilidade e uso racional dos recursos.

5.2.2 Membros Técnicos – Apoio Técnico e Operacional

Atuam como suporte técnico na execução das atividades de gestão de materiais e equipamentos, sob supervisão do Gestor.

Principais atribuições:

- Apoiar no controle e registro de materiais e insumos anestésicos;
- Acompanhar manutenção, testagem e rastreabilidade de equipamentos;
- Realizar checagem de validade, integridade e conformidade dos materiais;
- Monitorar consumo e sugerir melhorias em processos de reposição e armazenamento;
- Auxiliar em treinamentos e orientações de uso seguro;

- Reportar falhas, incidentes e não conformidades ao Gestor do Comitê;
- Participar ativamente das reuniões e planos de ação do Comitê.

6. Reuniões

As reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente, preferencialmente antes do fechamento contábil e das aquisições planejadas.

Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Coordenador do Comitê ou pelo Comitê Executivo de Gestão.

Cada reunião deverá ter pauta pré-definida, ata registrada e plano de ação com responsáveis e prazos definidos.

7. Deliberações e Encaminhamentos

As decisões do Comitê têm caráter consultivo e técnico, sendo validadas pelo Gestor do Comitê e pelo Coordenador Geral.

Recomendações que envolvam impacto financeiro ou aquisição de tecnologia deverão ser submetidas à aprovação na Assembleia Geral.

As deliberações deverão estar embasadas em dados técnicos, evidências científicas e princípios de governança corporativa.

8. Vigência e Revisão

Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação e deverá ser revisado anualmente ou sempre que houver alterações tecnológicas, normativas ou estruturais relevantes.

9. Princípios Éticos e de Governança

O Comitê deverá pautar suas ações nos seguintes princípios:

- Segurança e confiabilidade tecnológica;
- Transparência e rastreabilidade dos processos;

- Sustentabilidade e responsabilidade ambiental;
- Conformidade regulatória e ética profissional;
- Inovação contínua e gestão baseada em evidências;
- Alinhamento às metas estratégicas e valores institucionais.

B) COMITÊ DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E RESIDÊNCIA MÉDICA

1. Identidade Organizacional

Nosso Negócio

Somos um grupo de anestesiologistas comprometidos com atuação abrangente em todas as áreas da anestesiologia, manejo da dor, cuidados intensivos, ensino e pesquisa.

Nossa Missão

Proporcionar cuidados anestésicos de excelência, garantindo segurança, conforto e bem-estar. Atuamos com inovação e qualificação contínua em ambiente colaborativo e sustentável.

Nossa Visão

Ser reconhecido como centro de excelência em anestesiologia na macrorregião sul, destacando-se pela inovação, qualidade e segurança.

Princípios e Valores

Segurança • Ética • União • Colaboração • Governança • Transparência • Sustentabilidade • Excelência • Inovação • Humanização

Política de Qualidade

Comprometidos com a excelência em anestesiologia, promovemos segurança, qualidade e cuidado humanizado em cada etapa do atendimento.

2. Finalidade

O Comitê de Educação Continuada e de Residência Médica tem como finalidade planejar, supervisionar e avaliar as atividades de formação profissional, ensino, capacitação e pesquisa desenvolvidas pelo Serviço de Anestesia.

Seu propósito é assegurar a qualidade educacional, promover atualização técnico-científica permanente e fomentar uma cultura institucional de aprendizado e pesquisa.

3. Subordinação Hierárquica

Conforme o organograma institucional vigente, o Comitê:

- Está subordinado ao Coordenador Geral e ao Comitê Executivo de Gestão;
- É coordenado de forma conjunta por dois gestores:
    1. **Coordenador de Educação Continuada**
    2. **Coordenador de Residência Médica**
- Atua em integração com os Comitês de Qualidade, Gestão de Pessoas e Escalas.

4. Composição

O Comitê é composto por:

- **Coordenador de Educação Continuada;**
- **Coordenador de Residência Médica;**
- **Membros Técnicos – anestesiologistas preceptores e representantes da enfermagem assistencial;**
- **Convidados – residentes, estagiários e assessores acadêmicos, conforme necessidade.**

A composição poderá ser revisada anualmente conforme diretrizes institucionais e exigências regulatórias.

5. Competências e Responsabilidades

5.1 Compete ao Comitê:

Planejar e executar programas de **educação continuada, residência médica e atualização científica**;

- Garantir a conformidade pedagógica e regulatória dos programas junto à CNRM e demais órgãos competentes;
- Promover eventos científicos, jornadas, seminários e treinamentos técnicos;
- Estimular a pesquisa clínica e a produção científica dos membros e residentes;
- Assegurar integração entre ensino, assistência e pesquisa;
- Avaliar continuamente o desempenho dos programas, participantes e preceptores;
- Zelar pela ética, pela transparência e pela qualidade das atividades educacionais.

5.2 Papéis e Responsabilidades

5.2.1. Coordenador de Educação Continuada

Responsável por planejar, supervisionar e avaliar as ações de capacitação, atualização e desenvolvimento técnico-profissional de toda a equipe de anestesia.

Principais atribuições:

- Planejar e coordenar o programa anual de educação continuada do Serviço de Anestesia;
- Identificar necessidades de capacitação com base em indicadores assistenciais e estratégicos;
- Elaborar e revisar cronogramas de treinamentos, cursos e jornadas científicas;
- Supervisionar o conteúdo técnico dos eventos e garantir alinhamento às boas práticas clínicas;

- Promover integração entre anestesiologistas, enfermeiros e demais profissionais da equipe multiprofissional;

- Avaliar a eficácia dos programas de treinamento por meio de indicadores de desempenho e satisfação;
- Incentivar o aprendizado permanente e o aprimoramento científico dos profissionais;
- Gerir registros, certificados e documentação das atividades educacionais;
- Apoiar a inovação pedagógica e o uso de tecnologias no ensino;
- Representar o Comitê em eventos e parcerias acadêmicas externas.

5.2.2. Coordenador de Residência Médica

Responsável por planejar, executar e supervisionar o Programa de Residência Médica em Anestesiologia, assegurando o cumprimento das normas da CNRM e a qualidade da formação médica.

Principais atribuições:

- Elaborar, revisar e implementar o projeto pedagógico da residência médica, conforme diretrizes da CNRM;
- Coordenar as atividades teóricas e práticas dos residentes;
- Elabora escala de atividades dos residentes;
- Designar preceptores e supervisionar a execução das atividades clínicas e científicas;
- Avaliar o desempenho dos residentes com base em critérios objetivos e formativos;
- Organizar reuniões clínicas, discussões de caso e jornadas acadêmicas da residência;
- Promover integração entre ensino e prática assistencial, estimulando pensamento crítico e tomada de decisão segura;
- Assegurar conformidade com normas éticas, regulatórias e institucionais;
- Estimular a produção científica e a participação dos residentes em eventos e publicações;

- Manter registros acadêmicos e administrativos atualizados junto à CNRM e instâncias internas;
- Representar o programa de residência perante órgãos externos e instituições parceiras.

C. Membros Técnicos – Apoio Científico e Pedagógico

Atuam como apoio operacional e técnico, contribuindo com o planejamento, execução e avaliação das atividades educacionais.

Principais atribuições:

- Ministrar treinamentos e atividades práticas sob supervisão dos coordenadores;
- Apoiar a elaboração de materiais didáticos e conteúdos de ensino;
- Participar da avaliação de residentes e profissionais capacitados;
- Promover a integração entre teoria e prática nos processos de ensino-aprendizagem;
- Contribuir com sugestões e melhorias no plano educacional do serviço.

6. Reuniões

As reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente, com pauta previamente definida, ata registrada e controle de presença.

Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por qualquer um dos coordenadores ou pelo Comitê Executivo de Gestão.

As deliberações deverão ser documentadas em planos de ação com prazos e responsáveis definidos.

7. Deliberações e Encaminhamentos

As decisões do Comitê têm caráter consultivo e pedagógico, devendo ser validadas pelos Coordenadores de Educação e de Residência e pelo Comitê Executivo de Gestão.

Propostas com impacto institucional, curricular ou financeiro deverão ser submetidas à Coordenação Geral.

As deliberações serão fundamentadas em evidências científicas, resultados educacionais e boas práticas de governança acadêmica.

8. Vigência e Revisão

Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação e deverá ser revisado anualmente ou sempre que houver mudanças nas diretrizes da CNRM ou nas políticas internas de ensino.

9. Princípios Éticos e de Governança

O Comitê de Educação Continuada e de Residência Médica deverá pautar suas ações em:

- Ética e integridade científica;
- Transparência e responsabilidade educacional;
- Respeito às normas regulatórias e aos princípios da governança clínica;
- Comprometimento com a excelência e a segurança do paciente;
- Integração entre ensino, assistência e pesquisa;
- Valorização do corpo docente, discente e preceptor;
- Busca permanente pela inovação e pela melhoria do processo educacional.

C) COMITÊ DE ESCALAS

1. Identidade Organizacional

Nosso Negócio

Somos um grupo de anestesiologistas comprometidos com atuação abrangente em todas as áreas da anestesiologia, manejo da dor, cuidados intensivos, ensino e pesquisa.

Nossa Missão

Proporcionar cuidados anestésicos de excelência, garantindo segurança, conforto e bem-estar. Atuamos com inovação e qualificação contínua em ambiente colaborativo e sustentável.

Nossa Visão

Ser reconhecido como centro de excelência em anestesiologia na macrorregião sul, destacando-se pela inovação, qualidade e segurança.

Princípios e Valores

Segurança • Ética • União • Colaboração • Governança • Transparência • Sustentabilidade • Excelência • Inovação • Humanização

Política de Qualidade

Comprometidos com a excelência em anestesiologia, promovemos segurança, qualidade e cuidado humanizado em cada etapa do atendimento.

2. Finalidade

O Comitê de Escalas tem como finalidade planejar, organizar e monitorar a distribuição das atividades assistenciais da equipe de anestesia, garantindo a continuidade do atendimento, a conformidade trabalhista e o equilíbrio de carga horária entre os profissionais.

Seu propósito é otimizar recursos humanos, assegurar previsibilidade nas operações e manter a cobertura anestésica adequada às demandas dos serviços hospitalares e ambulatoriais.

3. Subordinação Hierárquica

De acordo com o organograma institucional vigente, o Comitê de Escalas:

- Está subordinado ao Coordenador Geral e integra o Comitê Executivo de Gestão;

- É coordenado pelo Coordenador do Comitê de Escalas;
- Atua em estreita colaboração com os demais Comitês e responsáveis pelo Consultório, Assistência Hospitalar, Anestesia Ambulatorial e Qualidade.

4. Composição

O Comitê é composto por:

- **Coordenador de Escalas – Coordenador do Comitê;**
- **Membros Técnicos – anestesiologistas e enfermeira;**
- **Convidados – conforme necessidade (ex: coordenador hospitalar, responsável técnico, setor administrativo).**

A composição poderá ser revisada periodicamente conforme as necessidades operacionais e diretrizes estratégicas.

5. Competências e Responsabilidades

5.1 Compete ao Comitê de Escalas:

- Planejar e distribuir escalas mensais e extraordinárias da equipe de anestesia, considerando carga horária, disponibilidade e perfil técnico;
- Garantir a cobertura assistencial contínua em todas as unidades hospitalares, ambulatoriais e de dor;
- Assegurar equidade na distribuição de plantões, folgas e compensações;
- Manter conformidade com normas trabalhistas, éticas e regulatórias aplicáveis à profissão médica e de enfermagem;
- Validar alterações e trocas de plantão, registrando formalmente as modificações;
- Analisar demandas sazonais, licenças e ausências para ajustes operacionais;
- Apoiar a Coordenação Geral na elaboração de escalas especiais (feriados, férias, sobreavisos);
- Garantir comunicação tempestiva e clara sobre as escalas a toda a equipe;

- Atuar de forma integrada com o Comitê de Gestão de Pessoas e o Comitê de Qualidade, visando segurança assistencial e satisfação da equipe.

5.2 Papéis e Responsabilidades dos Integrantes

5.2.1 Coordenador do Comitê

É o responsável pela liderança técnica e administrativa do Comitê, assegurando a gestão ética, eficiente e transparente das escalas.

Principais atribuições:

- Planejar, revisar e publicar as escalas mensais de anestesia;
- Supervisionar a execução das escalas, garantindo cobertura total dos serviços;
- Validar trocas, substituições e ajustes extraordinários;
- Manter o registro histórico das escalas e ausências justificadas;
- Garantir conformidade com legislações trabalhistas e regulamentações médicas;
- Promover reuniões com a equipe para alinhamento e avaliação das escalas;
- Atuar como mediador em conflitos ou divergências relacionadas à carga horária;
- Integrar-se aos demais comitês para alinhamento estratégico e operacional.

5.2.2 Membros Técnicos – Apoio Operacional e Analítico

Atuam no suporte técnico e administrativo ao planejamento e controle das escalas.

Principais atribuições:

- Auxiliar na coleta de dados sobre disponibilidade e jornadas de trabalho;
- Realizar lançamentos e conferências de escalas em sistemas de registro;
- Apoiar o monitoramento de indicadores de assiduidade e cobertura assistencial;

- Manter comunicação direta com a equipe em relação a mudanças ou ajustes;
- Contribuir com sugestões de melhoria e otimização dos processos de escala.

6. Reuniões

- As reuniões ordinárias ocorrerão mensalmente, preferencialmente antes da publicação da escala subsequente.
- Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Coordenador do Comitê ou pelo Comitê Executivo de Gestão.
- Cada reunião deverá ter pauta pré-definida, ata registrada e plano de ação com prazos e responsáveis.

7. Deliberações e Encaminhamentos

- As decisões do Comitê de Escalas têm caráter consultivo e operacional, sendo validadas pelo Coordenador do Comitê e pelo Coordenador Geral.
- Recomendações que impactem custos, carga horária ou contratos deverão ser submetidas à aprovação da Assembleia Geral.
- As deliberações devem estar fundamentadas em critérios técnicos, dados objetivos e princípios de equidade.

8. Vigência e Revisão

Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação e deverá ser revisado anualmente ou sempre que houver alterações estruturais, normativas ou estratégicas que impactem o processo de gestão de escalas.

9. Princípios Éticos e de Governança

- O Comitê de Escalas deverá pautar suas ações nos seguintes princípios:
- Transparência e justiça na distribuição de horários e plantões;
- Respeito às legislações trabalhistas e às normas médicas vigentes;

- Responsabilidade e comprometimento com a continuidade assistencial;
- Imparcialidade e ética profissional nas decisões;
- Integração e comunicação efetiva entre os membros da equipe;
- Busca constante pela eficiência e pela sustentabilidade operacional.

D) COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS

1. Identidade Organizacional

Nosso Negócio

Somos um grupo de anestesiologistas comprometidos com atuação abrangente em todas as áreas da anestesiologia, manejo da dor, cuidados intensivos, ensino e pesquisa.

Nossa Missão

Proporcionar cuidados anestésicos de excelência, garantindo segurança, conforto e bem-estar. Atuamos com inovação e qualificação contínua em ambiente colaborativo e sustentável.

Nossa Visão

Ser reconhecido como centro de excelência em anestesiologia na macrorregião sul, destacando-se pela inovação, qualidade e segurança.

Princípios e Valores

Segurança • Ética • União • Colaboração • Governança • Transparência • Sustentabilidade • Excelência • Inovação • Humanização

Política de Qualidade

Comprometidos com a excelência em anestesiologia, promovemos segurança, qualidade e cuidado humanizado em cada etapa do atendimento.

2. Finalidade

O Comitê de Gestão de Pessoas tem como finalidade planejar, coordenar e acompanhar as políticas e práticas relacionadas à gestão de pessoas no Serviço de Anestesia, abrangendo:

- recrutamento, seleção e integração;
- capacitação e desenvolvimento profissional;
- gestão de desempenho e clima organizacional;
- reconhecimento e retenção de talentos;
- e promoção da saúde ocupacional e qualidade de vida.

Seu propósito é fortalecer a cultura organizacional, assegurar conformidade legal e promover o engajamento e o desenvolvimento contínuo das equipes.

3. Subordinação Hierárquica

De acordo com o organograma institucional vigente, o Comitê de Gestão de Pessoas:

- Está subordinado ao Coordenador Geral e articula-se com o Comitê Executivo de Gestão;
- É coordenado pelo Gestor de Pessoas, que responde diretamente ao Coordenador Geral;
- Atua de forma integrada com os comitês de Qualidade, Financeiro e Tecnologia e Materiais.

4. Composição

O Comitê é composto por:

- **Coordenador de Pessoas – Coordenador do Comitê;**
- **Membros Técnicos – anestesiologistas e enfermeira.**

A composição poderá ser revista periodicamente conforme diretrizes estratégicas e necessidades operacionais do Serviço de Anestesia.

5. Competências e Responsabilidades

5.1 Compete ao Comitê de Gestão de Pessoas:

- Planejar e executar as políticas de gestão de pessoas alinhadas às diretrizes institucionais;
- Monitorar indicadores de desempenho humano (turnover, absenteísmo, engajamento, capacitação);
- Elaborar planos de desenvolvimento individual e institucional;
- Apoiar processos de recrutamento, seleção e integração de novos colaboradores;
- Promover ações de educação continuada, estágios e programas de aperfeiçoamento;
- Garantir conformidade com normas trabalhistas, éticas e de segurança ocupacional;
- Zelar por um ambiente de trabalho saudável, colaborativo e livre de assédio;
- Gerir avaliações de desempenho e propor planos de reconhecimento e valorização;
- Assessorar a coordenação geral nas decisões estratégicas relacionadas a pessoas.

5.2 Papéis e Responsabilidades dos Integrantes

5.2.1 Coordenador do Comitê de Gestão de Pessoas

Responsável por conduzir, supervisionar e garantir o alinhamento das práticas de gestão de pessoas com os objetivos estratégicos da clínica.

- Presidir reuniões do Comitê e validar planos de ação.
- Garantir conformidade legal, ética e institucional nas relações de trabalho.
- Representar o Comitê junto ao Comitê Executivo e demais instâncias institucionais.
- Promover a integração e o desenvolvimento da equipe.
- Estimular cultura de feedback, aprendizado e melhoria contínua.
- Gerenciar a escala de trabalho da equipe de anestesia.
- Acompanhar processos de contratação e desligamento de profissionais.
- Elaborar e supervisionar o plano de cargos, funções e salários.
- Monitorar a folha de pagamento e benefícios.
- Avaliar o desempenho da equipe.
- Promover o bem-estar e a satisfação da equipe.

- Supervisionar a conformidade com normas trabalhistas e éticas.
- Realizar treinamentos e capacitações.
- Controlar custos relacionados à força de trabalho.
- Manter registros administrativos e trabalhistas atualizados.
- Apoiar a comunicação interna da equipe.
- Representar a equipe em negociações e reuniões estratégicas.
- Promover integração intersetorial e alinhamento organizacional.

5.2.2 Atribuições dos Membros Técnicos – Apoio Administrativo e Assistencial

- Apoiar o Comitê nas ações operacionais, técnicas e educacionais.
- Prestar apoio técnico ao Coordenador na definição, planejamento e desdobramento das ações do Comitê.
- Coletar, organizar e analisar dados de desempenho humano, clima organizacional e indicadores de gestão de pessoas.
- Contribuir para a elaboração e atualização dos planos de capacitação, desenvolvimento e integração institucional.
- Participar ativamente das reuniões do Comitê, colaborando na construção de relatórios, registros e planos de ação.
- Garantir a disseminação e aplicação das políticas, normas e diretrizes institucionais em suas respectivas áreas de atuação.
- Apoiar a execução de programas de desenvolvimento profissional, educação continuada e qualidade de vida no trabalho.
- Colaborar na identificação de necessidades de melhoria nos processos de gestão de pessoas e propor soluções alinhadas às diretrizes do Comitê.
- Assegurar a comunicação efetiva entre o Comitê e as equipes assistenciais e administrativas.
- Participar do monitoramento das metas e resultados definidos pelo Comitê.

6. Reuniões

As reuniões ordinárias ocorrerão mensalmente, com pauta definida e ata registrada.

Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Gestor de Pessoas ou pelo Comitê Executivo.

As deliberações resultarão em planos de ação com prazos, responsáveis e indicadores de acompanhamento.

7. Deliberações e Encaminhamentos

- As decisões do Comitê têm caráter consultivo e propositivo, devendo ser validadas pelo **Coordenador Geral.**
- Recomendações com impacto institucional ou trabalhista serão submetidas à aprovação da **Assembleia Geral.**
- As deliberações devem estar fundamentadas em dados técnicos, éticos e de governança institucional.

8. Vigência e Revisão

- Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação e deverá ser revisado anualmente ou sempre que houver alterações estruturais ou normativas relevantes.

9. Princípios Éticos e de Governança

O Comitê deve pautar suas ações em:

- Ética, confidencialidade e respeito à dignidade humana;
- Transparência e equidade nas relações de trabalho;
- Conformidade legal e regulatória;
- Desenvolvimento sustentável das equipes;
- Compromisso com a segurança e humanização do cuidado.

E) COMITÊ DE QUALIDADE

1. Identidade Organizacional

Nosso Negócio

Somos um grupo de anestesiologistas comprometidos com atuação abrangente em todas as áreas da anestesiologia, manejo da dor, cuidados intensivos, ensino e pesquisa.

Nossa Missão

Proporcionar cuidados anestésicos de excelência, garantindo segurança, conforto e bem-estar. Atuamos com inovação e qualificação contínua em ambiente colaborativo e sustentável.

Nossa Visão

Ser reconhecido como centro de excelência em anestesiologia na macrorregião sul, destacando-se pela inovação, qualidade e segurança.

Princípios e Valores

Segurança • Ética • União • Colaboração • Governança • Transparência • Sustentabilidade • Excelência • Inovação • Humanização

Política de Qualidade

Comprometidos com a excelência em anestesiologia, promovemos segurança, qualidade e cuidado humanizado em cada etapa do atendimento.

2. Finalidade

O Comitê de Qualidade tem como finalidade planejar, implementar e monitorar ações voltadas à segurança do paciente, qualidade assistencial, conformidade regulatória e melhoria contínua dos processos no Serviço de Anestesia, abrangendo Consultório, Assistência Hospitalar, Anestesia Ambulatorial, Ambulatório de Dor e Comunicação Interna e Externa.

Seu propósito é garantir a padronização técnica, o cumprimento de protocolos clínicos e operacionais, e o fortalecimento da cultura de qualidade e segurança, assegurando a obtenção e manutenção das certificações e acreditações institucionais e outras referências normativas nacionais e internacionais aplicáveis à área de saúde.

3. Subordinação Hierárquica

Conforme o organograma institucional vigente, o Comitê de Qualidade:

- Está subordinado ao Coordenador Geral e vinculado ao Comitê Executivo de Gestão;
- É coordenado pelo Gestor de Qualidade, que responde diretamente ao Coordenador Geral;
- Atua em cooperação com os comitês de Gestão de Pessoas, Financeiro e Tecnologia e Materiais;
- Mantém interface direta com os responsáveis pelas áreas de **Consultório, Assistência Hospitalar, Anestesia Ambulatorial, Ambulatório de Dor e Comunicação Interna e Externa**, assegurando alinhamento técnico, regulatório e documental para manutenção da conformidade com os padrões de acreditação vigentes.

4. Composição

O Comitê é composto por:

- Gestor de Qualidade – Coordenador do Comitê;
- Membros Técnicos – anestesiologistas, enfermeiros e representantes administrativos;
- Representantes Setoriais – responsáveis designados por cada área vinculada (consultório, assistência hospitalar, anestesia ambulatorial, ambulatório de dor e comunicação);
- Convidados Permanentes ou Eventuais – conforme necessidade (ex: CCIH, Segurança do Paciente, Farmácia, Engenharia Clínica).

A composição será revista periodicamente, considerando as diretrizes estratégicas, regulatórias e de acreditação institucional.

5. Competências e Responsabilidades

5.1 Compete ao Comitê de Qualidade:

- Planejar, coordenar e avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade do Serviço de Anestesia;
- Desenvolver, revisar e implementar protocolos clínicos, políticas e ROPs;
- Monitorar indicadores de qualidade, segurança e desempenho assistencial em todas as áreas;
- Investigar e tratar não conformidades, incidentes e eventos adversos, propondo ações corretivas e preventivas;
- Conduzir auditorias internas e acompanhar auditorias externas, certificações e avaliações de acreditação;
- Assegurar a manutenção das certificações e acreditações institucionais cumprindo requisitos normativos e regulatórios;
- Avaliar a satisfação de pacientes e colaboradores, promovendo planos de melhoria contínua;
- Promover educação continuada voltada à segurança do paciente, ética e boas práticas assistenciais;
- Garantir a conformidade com normas legais, sanitárias e regulatórias (ANVISA, CFM, COREN, RDCs, entre outras);
- Apoiar o planejamento estratégico institucional, com base em dados de desempenho e evidências;
- Fomentar a cultura de segurança, transparência e aprendizado organizacional, promovendo comunicação aberta e responsabilidade compartilhada.

5.2 Papéis e Responsabilidades dos Integrantes

5.2.1 Coordenador da Qualidade – Coordenador do Comitê

Responsável por liderar tecnicamente as ações de qualidade, assegurando o alinhamento das práticas assistenciais, administrativas e documentais aos padrões institucionais, regulatórios e de acreditação.

Atribuições principais:

- Coordenar e supervisionar todas as atividades e subgrupos vinculados ao Comitê;
- Presidir reuniões, definir pautas e garantir execução das deliberações;
- Validar relatórios de auditoria, planos de ação e evidências de conformidade;
- Representar o Comitê perante o Comitê Executivo de Gestão e órgãos certificadores;
- Monitorar a obtenção e manutenção da acreditação Qmentum International e demais programas;
- Assegurar a atualização documental e o cumprimento dos requisitos normativos e regulatórios;
- Integrar as informações dos núcleos setoriais para garantir coerência e rastreabilidade institucional;
- Promover cultura de qualidade, segurança e conformidade contínua.

5.2.2 Membros Técnicos – Apoio Operacional e Analítico

Atuam na coleta, análise e documentação de evidências, além da execução de planos de ação corretiva e preventiva, com foco na manutenção das acreditações e certificações.

Atribuições:

- Coletar e consolidar indicadores e registros documentais exigidos pelos programas de acreditação;
- Apoiar a investigação de eventos adversos e não conformidades;
- Contribuir na elaboração, revisão e implementação de protocolos;
- Garantir a aplicação e conformidade das ROPs;

- Participar de treinamentos e auditorias internas e externas;
- Promover boas práticas assistenciais e administrativas com base nos padrões Qmentum e regulatórios

5.2.3 Representantes Setoriais (por área funcional)

1. **Consultório** – Garantir conformidade assistencial e documental conforme normas de acreditação;
2. **Assistência Hospitalar** – Supervisionar a aplicação dos protocolos de segurança e rastreabilidade cirúrgica;
3. **Anestesia Ambulatorial** – Monitorar processos relacionados à segurança anestésica e controle de materiais;
4. **Ambulatório de Dor** – Garantir aderência a protocolos clínicos e de satisfação do paciente;
5. **Comunicação Interna e Externa** – Divulgar resultados, ações de qualidade e conformidade regulatória, apoiando o engajamento institucional.

6. Reuniões

As reuniões ordinárias ocorrerão mensalmente, com pauta, ata e lista de presença formalizadas.
Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Gestor de Qualidade ou pelo Comitê Executivo de Gestão.
As deliberações serão registradas em planos de ação com responsáveis, prazos e evidências documentais, assegurando rastreabilidade perante auditorias e certificações.

7. Deliberações e Encaminhamentos

- As decisões do Comitê têm caráter consultivo e propositivo, validadas pelo Gestor de Qualidade e pelo Coordenador Geral.

- As recomendações com impacto institucional serão submetidas ao Comitê executivo de Gestão e à Assembleia Geral, observando normas de acreditação, políticas institucionais e legislação vigente.
- Todas as deliberações devem basear-se em evidências auditáveis, indicadores de desempenho e princípios de governança clínica.

8. Vigência e Revisão

Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação e deverá ser revisado anualmente ou sempre que houver mudanças em estruturas organizacionais, requisitos regulatórios, certificações ou programas de acreditação.

9. Princípios Éticos e de Governança

- O Comitê de Qualidade pautará suas ações pelos seguintes princípios:
- Segurança, ética e transparência em todas as práticas;
- Conformidade com legislações, normas sanitárias e padrões de acreditação;
- Rastreabilidade e prestação de contas (accountability);
- Sustentabilidade e eficiência dos processos institucionais;
- Alinhamento com missão, visão e valores organizacionais;
- Comprometimento com a excelência, a humanização e a melhoria contínua.

F) COMITÊ FINANCEIRO

1. Identidade Organizacional

Nosso Negócio

Somos um grupo de anestesiologistas comprometidos com atuação abrangente em todas as áreas da anestesiologia, manejo da dor, cuidados intensivos, ensino e pesquisa.

Nossa Missão

Proporcionar cuidados anestésicos de excelência, garantindo segurança, conforto e bem-estar. Atuamos com inovação e qualificação contínua em ambiente colaborativo e sustentável.

Nossa Visão

Ser reconhecido como centro de excelência em anestesiologia na macrorregião sul, destacando-se pela inovação, qualidade e segurança.

Princípios e Valores

Segurança • Ética • União • Colaboração • Governança • Transparência • Sustentabilidade • Excelência • Inovação • Humanização

Política de Qualidade

Comprometidos com a excelência em anestesiologia, promovemos segurança, qualidade e cuidado humanizado em cada etapa do atendimento.

O Comitê Financeiro fundamenta suas atividades nesses princípios e compromissos institucionais, garantindo que suas decisões financeiras estejam sempre alinhadas à missão e à visão organizacional.

2. Finalidade

O Comitê Financeiro tem como finalidade planejar, monitorar e avaliar a gestão financeira do Serviço de Anestesia, assegurando eficiência econômica, transparência nos processos e conformidade com as diretrizes institucionais e legais.

Seu propósito é suportar decisões estratégicas, promover o uso racional de recursos e garantir a sustentabilidade operacional e financeira do serviço.

3. Subordinação Hierárquica

De acordo com o organograma institucional vigente, o Comitê Financeiro:

- Está subordinado ao Coordenador Geral, ao qual reporta análises, indicadores e recomendações.
- É coordenado pelo Coordenador Financeiro do Serviço de Anestesia, que responde diretamente ao Coordenador Geral e atua em articulação com o Responsável Técnico.
- Atua de forma integrada com os demais comitês e áreas de apoio administrativo, contábil e estratégico.

4. Composição

O Comitê é composto por:

- **Coordenador Financeiro** – Presidente do Comitê;
- **Membros do Comitê** – Apoio técnico-administrativo;
- **Convidados -** conforme necessidade

A composição poderá ser revista periodicamente pelo Coordenador Geral e Comitê Executivo de Gestão, conforme necessidades operacionais e diretrizes estratégicas.

5. Competências e Responsabilidades

5.1 Compete ao Comitê Financeiro:

1. Elaborar e acompanhar o orçamento anual do Serviço de Anestesia, alinhado às metas estratégicas e institucionais.
2. Monitorar receitas, despesas e indicadores financeiros, propondo medidas corretivas e preventivas.
3. Gerir contratos e negociações financeiras com operadoras, fornecedores e prestadores de serviço.
4. Supervisionar o faturamento e a cobrança de procedimentos anestésicos, garantindo integridade e minimização de glosas.
5. Analisar investimentos e despesas de capital, emitindo pareceres sobre viabilidade econômica.

6. Assegurar conformidade fiscal e regulatória, zelando pela emissão correta de notas fiscais e cumprimento das obrigações legais.
7. Delegar funções aos membros do Comitê, supervisionar a execução das tarefas e avaliar resultados.
8. Emitir relatórios financeiros periódicos ao Comitê Executivo de Gestão e ao Coordenador Geral.
9. Contribuir com o planejamento estratégico institucional, oferecendo subsídios financeiros para a tomada de decisão.
10. Atuar de forma articulada com outros comitês, especialmente o de Qualidade, Tecnologia e Materiais, e Gestão de Pessoas, promovendo coerência e sustentabilidade entre os processos.

5.2 Papéis e Responsabilidades dos Integrantes do Comitê Financeiro

Coordenador Financeiro – Presidente do Comitê - é o líder técnico e estratégico do Comitê Financeiro, responsável por conduzir as atividades do grupo e assegurar que todas as ações estejam alinhadas à missão, visão e política institucional do Serviço de Anestesia.

Principais responsabilidades:

1. Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades do Comitê Financeiro.
2. Presidir as reuniões, definir pautas e garantir a execução das deliberações.
3. Representar o Comitê perante o Coordenador Geral, o Comitê Executivo de Gestão e demais instâncias institucionais.
4. Delegar funções aos membros do comitê, acompanhando a execução e avaliando o desempenho de cada área sob sua responsabilidade.
5. Garantir a integridade e rastreabilidade das informações financeiras, zelando pela conformidade fiscal, contábil e ética.
6. Aprovar e validar relatórios financeiros, análises de custos e indicadores de desempenho, encaminhando-os às instâncias superiores.
7. Promover a integração intercomitês, articulando-se com os comitês de Qualidade, Tecnologia e Materiais, e Gestão de Pessoas.
8. Incentivar o desenvolvimento técnico e a educação continuada dos membros do comitê, fomentando a cultura de melhoria contínua e inovação.

9. Assegurar a confidencialidade dos dados e documentos sob sua gestão.
10. Responder pelos resultados financeiros e administrativos do serviço de anestesia, conforme diretrizes da coordenação geral.

O Coordenador Financeiro é, portanto, o elo entre a gestão estratégica e a execução operacional, garantindo que as decisões financeiras estejam sustentadas por análises técnicas, transparência e responsabilidade institucional.

Membros do Comitê – Apoio Técnico-Administrativo: Atuam como apoio técnico, analítico e operacional, colaborando diretamente com o Coordenador Financeiro na execução das atividades e metas estabelecidas.

Principais responsabilidades:

1. Executar as atividades financeiras e administrativas designadas pelo Coordenador Financeiro, observando prazos, normas e procedimentos internos.
2. Coletar, consolidar e analisar dados financeiros (receitas, despesas, custos operacionais, contratos e indicadores).
3. Elaborar relatórios e demonstrativos financeiros sob supervisão do Coordenador Financeiro.
4. Auxiliar na elaboração e acompanhamento do orçamento anual, oferecendo suporte técnico e administrativo.
5. Monitorar processos de faturamento e cobrança, contribuindo para a acurácia dos lançamentos e redução de glosas.
6. Registrar e organizar documentos financeiros e atas de reuniões, assegurando rastreabilidade e integridade da informação.
7. Participar ativamente das reuniões, contribuindo com análises, sugestões e avaliações de desempenho econômico.
8. Identificar oportunidades de melhoria nos processos financeiros e administrativos, propondo soluções alinhadas à sustentabilidade do serviço.
9. Cumprir e disseminar os princípios éticos e de governança institucional, agindo com integridade e sigilo profissional.

10. Cooperar na comunicação intersetorial, garantindo fluxo contínuo de informações com as áreas assistenciais, administrativas e contábeis.

6. Reuniões

- As reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente, preferencialmente antes do fechamento contábil.
- Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Coordenador Financeiro ou pelo Comitê Executivo de Gestão.
- Cada reunião deverá possuir pauta pré-definida, ata registrada e controle de presença.

As decisões e ações decorrentes serão documentadas em planos de ação com responsáveis e prazos definidos.

7. Deliberações e Encaminhamentos

- As decisões do Comitê têm caráter consultivo e propositivo, sendo validadas pelo Coordenador Geral.

- Recomendações com impacto orçamentário ou institucional serão submetidas à aprovação em Assembleia Geral.
- As deliberações devem estar fundamentadas em dados financeiros auditáveis, análises técnicas e princípios de governança corporativa.

8. Vigência e Revisão

Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Comitê Executivo de Gestão e pelo Coordenador Geral do Serviço de Anestesia.

Deverá ser revisado anualmente ou sempre que houver alterações estruturais, normativas ou estratégicas relevantes.

9. Princípios Éticos e de Governança

O Comitê deverá pautar suas ações nos seguintes princípios:

- Transparência e integridade nas práticas financeiras;
- Accountability (prestação de contas) e rastreabilidade das decisões;
- Imparcialidade e sigilo profissional;
- Eficiência e sustentabilidade na aplicação dos recursos;
- Alinhamento com a missão, visão e valores organizacionais;
- Comprometimento com a segurança, qualidade e humanização do cuidado.